

Buku Ajar

ETIK, HUKUM, DAN PROFESIONALISME

PRAKTIK KEBIDANAN DI INDONESIA

Siti Nur Umariyah Febriyanti • Dida Wanti • Intan Rina Susilawati

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



BUKU AJAR

ETIK, HUKUM, DAN PROFESIONALISME

PRAKTIK KEBIDANAN DI INDONESIA

Penulis:

Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH.

Dida Wanti, S.Tr.Keb., SKM., M.H(Kes).

Intan Rina Susilawati, SST., Bdn., M.Keb.

Editor:

Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



BUKU AJAR
ETIK, HUKUM, DAN PROFESIONALISME PRAKTIK KEBIDANAN DI INDONESIA

Penulis:

Bd.Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH.

Dida Wanti, S.Tr.Keb., SKM., M.H(Kes).

Intan Rina Susilawati, SST., Bdn., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Muftililah, S.SIT., M.Sc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-62-6

Cetakan Pertama : Juli, 2026

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga Buku Ajar Etik, Hukum, dan Profesionalisme Praktik Kebidanan di Indonesia ini dapat disusun sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, praktisi kebidanan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pelayanan kebidanan yang bermutu, aman, beretika, dan bertanggung jawab.

Profesi bidan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, anak, keluarga, dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, bidan tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga harus mampu memahami nilai-nilai etik, ketentuan hukum, serta prinsip profesionalisme yang menjadi dasar dalam setiap tindakan pelayanan kebidanan. Pemahaman terhadap etik dan hukum sangat diperlukan agar bidan mampu memberikan pelayanan sesuai kewenangan, menghormati hak pasien, menjaga keselamatan ibu dan bayi, serta bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan tindakan profesional yang dilakukan.

Buku ajar ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar etik kebidanan, prinsip moral dalam pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban bidan serta pasien, aspek hukum dalam praktik kebidanan, informed consent, kerahasiaan pasien, tanggung jawab profesional, keselamatan pasien, serta penerapan profesionalisme dalam berbagai situasi pelayanan kebidanan. Selain itu, buku ini juga membahas pentingnya sikap empati, komunikasi yang baik, pengambilan keputusan etis, serta kemampuan bidan dalam menghadapi dilema etik dan hukum yang mungkin terjadi dalam praktik sehari-hari.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya tantangan dalam pelayanan kebidanan di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, regulasi pelayanan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak kesehatan menuntut bidan untuk selalu bekerja secara profesional, hati-hati, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan kebidanan perlu membekali mahasiswa dengan pemahaman yang kuat mengenai etik, hukum, dan profesionalisme agar mereka siap menjadi tenaga bidan yang kompeten, bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan yang berpusat pada perempuan, bayi, keluarga, dan masyarakat.

Materi dalam buku ajar ini disajikan secara sistematis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Pembahasan disusun agar mahasiswa tidak hanya memahami

teori, tetapi juga mampu mengaitkan konsep etik dan hukum dengan kasus-kasus yang sering dijumpai dalam praktik kebidanan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan secara tepat, serta menerapkan nilai-nilai profesional dalam pelayanan kebidanan.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi keluasan materi, kedalaman pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, bidan, dan seluruh pembaca, serta menjadi salah satu kontribusi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan praktik kebidanan di Indonesia.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 KODE ETIK BIDAN DAN STANDAR PERILAKU PROFESIONAL:

INTEGRITAS, KEJUJURAN, DAN TANGGUNG JAWAB.....	1
A. Konsep Dasar Kode Etik Bidan dan Standar Perilaku Profesional.....	3
B. Integritas dalam Praktik Kebidanan	7
C. Kejujuran dalam Pelayanan Kebidanan	10
D. Tanggung Jawab Profesional Bidan.....	14
E. Evaluasi Perilaku Profesional dan Penanganan Pelanggaran Etika dan Moral	17
F. Simulasi / Roleplay Komunikasi Profesional Kebidanan.....	20
G. Checklist Observasi Komunikasi Profesional.....	22
H. Rubrik Penilaian Cpmk.....	23
I. Ringkasan	24
J. Daftar Pustaka.....	28

BAB 2 STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR PROFESI KEBIDANAN:

MUTU, KESELAMATAN PASIEN, DAN AKUNTABILITAS.....	35
A. Konsep Standar dalam Praktik Kebidanan.....	36
B. Standar Pelayanan Kebidanan	37
C. Standar Profesi Kebidanan	38
D. Mutu Pelayanan Kebidanan	38
E. Keselamatan Pasien dalam Kebidanan	39
F. Akuntabilitas dalam Praktik Kebidanan	39
G. Integrasi Mutu, Keselamatan, dan Akuntabilitas	40
H. Isu dan Tantangan Kontemporer	40
I. Sintesis Akademik.....	40
J. Sistem Asesmen Pembelajaran	40
K. Rubrik Penilaian.....	41
L. Mini Kasus (HOTS)	43
M. Ringkasan	51
N. Daftar Pustaka.....	52

BAB 3 INFORMED CONSENT DAN INFORMED CHOICE: PROSES, DOKUMENTASI DAN SITUASI KHUSUS	55
A. Pengertian Informed Consent dan Informed Choice.....	57
B. Dasar Hukum Informed Consent	59
C. Jenis, Fungsi dan Isi Informed Consent	60
D. Langkah-langkah Standart Procedure Operational (SPO) Informed Consent	61
E. Situasi Khusus dalam Informed Consent.....	62
F. Dokumentasi Informed Consent	63
G. Latihan Kasus.....	64
H. Soal Osce Kebidanan.....	65
I. Tabel. Portofolio pada Informed Consent/Informed Choice kasus Perdarahan PostPartum yang akan dilakukan KBI/KBE.....	78
J. Ringkasan	87
K. Daftar Pustaka.....	88
 PROFIL PENULIS	 91

BAB 1

KODE ETIK BIDAN DAN STANDAR PERILAKU PROFESIONAL: INTEGRITAS, KEJUJURAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, integritas, dan kepatuhan etika dalam praktik pelayanan kebidanan/ kesehatan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3; CPMK-6
CPL-2	Menerapkan hukum, regulasi, dan standar profesi untuk menjamin praktik yang sah, aman, dan akuntabel.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-3	Mengambil keputusan berbasis etika dengan mempertimbangkan hak pasien, keselamatan pasien, dan konteks sosial-budaya.	CPMK-2; CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan komunikasi profesional dan kolaborasi efektif dengan pasien/keluarga serta tim kesehatan, termasuk pengelolaan konflik kepentingan.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Menyelenggarakan dokumentasi dan pengelolaan informasi kesehatan secara akurat, aman, serta menjaga kerahasiaan dan privasi data.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melakukan refleksi, pembelajaran sepanjang hayat, pengembangan profesional berkelanjutan, serta menjunjung integritas ilmiah.	CPMK-3; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis landasan etik, hukum, dan profesionalisme serta keterkaitannya dalam praktik pelayanan kebidanan/ kesehatan di Indonesia.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-2	Menyusun keputusan pemecahan dilema etik berbasis prinsip dan nilai moral dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada kasus klinik.
CPMK-3	Mengevaluasi perilaku profesional sesuai kode etik dan standar profesi, termasuk komunikasi, batas profesional, dan konflik kepentingan, serta merumuskan strategi perbaikan.
CPMK-4	Menafsirkan regulasi dan standar terkait kewenangan, perizinan, serta ruang lingkup praktik untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas pelayanan.
CPMK-5	Merancang dan mendokumentasikan proses informed consent/informed choice serta tindakan pada situasi khusus (termasuk kegawatdaruratan) sesuai ketentuan etik-hukum.
CPMK-6	Menerapkan prinsip kerahasiaan, privasi, dan perlindungan data pasien dalam pengelolaan rekam medis serta pertukaran informasi profesional.
CPMK-7	Merancang strategi mutu dan keselamatan pasien melalui manajemen risiko, pelaporan insiden/RCA, pencegahan malpraktik, kolaborasi/rujukan, serta integritas penelitian dan pengembangan profesional.

A. Konsep Dasar Kode Etik Bidan dan Standar Perilaku Profesional

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai nilai-nilai moral, prinsip benar dan salah, serta pedoman yang mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan profesional. Dalam konteks pelayanan kesehatan, etika berfungsi sebagai dasar moral yang mengatur hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien, keluarga pasien, masyarakat, serta dengan sesama tenaga kesehatan. Etika membantu tenaga kesehatan dalam menentukan tindakan yang benar, adil, dan bertanggung jawab ketika menghadapi berbagai situasi klinis yang kompleks (Yulianti, 2022). Dalam profesi kebidanan, etika memiliki peranan yang sangat penting karena pelayanan yang diberikan oleh bidan berkaitan langsung dengan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Pelayanan tersebut melibatkan berbagai keputusan klinis yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan medis, tetapi juga pada pertimbangan moral dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, profesi kebidanan membutuhkan suatu pedoman yang dapat mengatur perilaku profesional para anggotanya. Pedoman tersebut dikenal sebagai kode etik profesi kebidanan.

Kode etik profesi kebidanan merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang disusun oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku profesional bidan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik berfungsi sebagai pedoman yang membantu bidan dalam menentukan sikap dan tindakan yang sesuai dengan standar profesional serta nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan (Setianingsih et al., 2021). Selain itu, kode etik juga memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima maupun yang tidak dapat diterima dalam praktik kebidanan. Dengan adanya kode etik, bidan memiliki pedoman yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai dilema etika yang mungkin muncul selama menjalankan praktik pelayanan kebidanan. Menurut berbagai kajian dalam literatur kebidanan, kode etik profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga integritas profesi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Dengan kata lain, kode etik membantu memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara profesional, aman, dan berorientasi pada kepentingan pasien (Ayesha Hendriana Ngestiningrum et al., 2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kode etik bidan merupakan landasan moral dan profesional yang mengarahkan bidan dalam menjalankan praktik kebidanan secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Kode etik dalam profesi kebidanan memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme serta perlindungan terhadap

pasien. Secara umum, tujuan utama dari kode etik bidan adalah untuk memberikan pedoman perilaku bagi bidan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan.

Salah satu tujuan utama kode etik adalah untuk menjaga kualitas pelayanan kebidanan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis tenaga kesehatan, tetapi juga oleh sikap dan perilaku profesional dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dengan adanya kode etik, bidan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesional serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik kebidanan (Sari & Solekah, 2025). Selain itu, kode etik juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien. Dalam pelayanan kesehatan, pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, pelayanan yang aman, serta perlakuan yang adil dan manusiawi. Kode etik membantu memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi oleh tenaga kesehatan, termasuk bidan (Hastuti et al., 2022). Tujuan lain dari kode etik adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kebidanan. Profesi kesehatan merupakan profesi yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tenaga kesehatan akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan yang efektif. Oleh karena itu, penerapan kode etik menjadi sangat penting dalam menjaga reputasi dan kredibilitas profesi kebidanan (Rahayu et al., 2023).

Kode etik juga berfungsi sebagai alat pengendalian profesi. Melalui kode etik, organisasi profesi dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku anggotanya serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga standar profesional serta memastikan bahwa seluruh anggota profesi menjalankan praktik sesuai dengan nilai-nilai etika yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kode etik bidan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa praktik kebidanan dilakukan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab.

Kode etik profesi kebidanan didasarkan pada berbagai prinsip etika yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan moral dalam pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip ini membantu tenaga kesehatan dalam menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi berbagai dilema etika dalam praktik klinis. Salah satu prinsip utama dalam etika kesehatan adalah prinsip otonomi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan keputusan terkait kesehatan dirinya sendiri. Dalam praktik kebidanan, prinsip otonomi diwujudkan melalui penghormatan terhadap keputusan pasien serta pemberian informasi yang lengkap sebelum tindakan medis dilakukan (Hastuti et al., 2022).

Prinsip kedua adalah *beneficence* atau prinsip berbuat baik. Prinsip ini menekankan bahwa tenaga kesehatan harus selalu berupaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pasien. Dalam praktik kebidanan, bidan harus memberikan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta mencegah terjadinya komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Prinsip ketiga adalah *nonmaleficence*, yaitu prinsip untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pasien. Prinsip ini sangat penting dalam praktik kebidanan karena setiap tindakan medis memiliki potensi risiko. Oleh karena itu, bidan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan telah dipertimbangkan secara matang dan memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan risikonya.

Prinsip berikutnya adalah keadilan (*justice*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Dalam praktik kebidanan, bidan harus memberikan pelayanan yang sama kepada setiap pasien tanpa memandang status sosial atau kondisi ekonomi mereka. Selain keempat prinsip tersebut, etika dalam praktik kebidanan juga mencakup prinsip kerahasiaan (*confidentiality*). Prinsip ini menuntut tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Informasi tersebut hanya boleh dibagikan kepada pihak yang berwenang dan memiliki kepentingan dalam pelayanan kesehatan pasien. Penerapan prinsip-prinsip etika tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kode etik profesi kebidanan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bidan dapat menjalankan praktik kebidanan secara profesional dan sesuai dengan nilai-nilai moral dalam pelayanan kesehatan.

Kode etik profesi kebidanan memiliki beberapa fungsi penting dalam praktik pelayanan kesehatan. Salah satu fungsi utama kode etik adalah sebagai pedoman perilaku profesional bagi bidan. Pedoman ini membantu bidan dalam menentukan sikap dan tindakan yang sesuai dengan standar profesi serta nilai-nilai moral dalam pelayanan kesehatan (Sari & Solekah, 2025). Fungsi lain dari kode etik adalah sebagai alat perlindungan bagi pasien. Melalui kode etik, pasien memiliki jaminan bahwa pelayanan yang mereka terima diberikan oleh tenaga kesehatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme.

Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan profesi, tetapi juga mengatur kehidupan profesional bidan dalam bersikap, berinteraksi, bekerja, dan bertanggung jawab terhadap pasien, masyarakat, sejawat, serta profesinya. Dengan adanya kode etik, profesi bidan dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan. Organisasi profesi dapat menggunakan kode etik sebagai dasar dalam menilai perilaku anggotanya serta memberikan sanksi terhadap

pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, kode etik membantu menjaga standar profesional dalam praktik kebidanan. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi anggota profesi. Melalui kode etik, bidan dapat memahami nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktik kebidanan. Hal ini sangat penting dalam membentuk karakter profesional yang berintegritas serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kode etik juga memiliki fungsi sebagai dasar dalam penyelesaian konflik etika. Dalam praktik kebidanan, bidan sering menghadapi berbagai situasi yang menimbulkan dilema etika, misalnya ketika terjadi konflik antara kepentingan pasien dengan kebijakan institusi kesehatan. Dalam situasi seperti ini, kode etik dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan keputusan yang paling tepat.

Profesionalisme merupakan salah satu aspek penting dalam praktik kebidanan. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kompetensi teknis, tetapi juga mencakup sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan integritas serta tanggung jawab dalam menjalankan profesi. Kode etik memiliki peran yang sangat penting dalam membangun profesionalisme bidan. Melalui kode etik, bidan memiliki pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dalam menjalankan praktik kebidanan. Hal ini membantu menciptakan standar perilaku profesional yang konsisten di antara anggota profesi (Bakri et al., 2025). Selain itu, kode etik juga membantu meningkatkan akuntabilitas dalam praktik kebidanan. Dengan adanya kode etik, bidan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan kepada pasien, masyarakat, dan organisasi profesi.

Kode etik juga berperan dalam menjaga hubungan profesional antara bidan dengan pasien, selain itu kode etik pun menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku secara profesional yang tentunya harus dipatuhi oleh seorang bidan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik berfungsi menjaga mutu pelayanan sekaligus membangun kepercayaan antara bidan dan masyarakat. hubungan tersebut harus didasarkan pada rasa saling percaya, penghormatan terhadap hak pasien, serta komunikasi yang jujur dan terbuka. Di era perkembangan teknologi informasi dan media sosial, penerapan kode etik menjadi semakin penting. Tenaga kesehatan harus mampu menjaga profesionalisme dalam berbagai situasi, termasuk dalam penggunaan media sosial. Pelanggaran terhadap kode etik dalam penggunaan media sosial dapat berdampak negatif terhadap reputasi profesi serta kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan (Rahayu et al., 2023). Dengan demikian, penerapan kode etik dalam praktik kebidanan tidak hanya bertujuan untuk mengatur perilaku profesional, tetapi juga untuk membangun citra profesi yang terpercaya dan berintegritas di mata masyarakat.

B. Integritas dalam Praktik Kebidanan

Integritas merupakan salah satu nilai fundamental dalam praktik profesi kesehatan, termasuk dalam profesi kebidanan. Integritas merujuk pada konsistensi antara nilai moral, prinsip etika, dan tindakan profesional yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dalam konteks pelayanan kesehatan, integritas menuntut tenaga kesehatan untuk bertindak secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan dalam setiap keputusan klinis yang diambil (Kabirian et al., 2024).

Profesi kebidanan merupakan profesi yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, khususnya kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh bidan harus didasarkan pada standar profesional yang tinggi serta nilai-nilai moral yang kuat. Integritas dalam praktik kebidanan berarti bahwa bidan tidak hanya memiliki kompetensi klinis yang memadai, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien (Shahabnia et al., 2020).

Integritas juga mencakup kemampuan bidan untuk mempertahankan prinsip profesional dalam berbagai situasi yang menantang, termasuk ketika menghadapi tekanan dari lingkungan kerja, kebijakan institusi, maupun tuntutan sosial budaya masyarakat. Dalam praktiknya, bidan sering menghadapi dilema etika yang memerlukan pertimbangan moral yang matang. Oleh karena itu, integritas menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan profesional dalam praktik kebidanan (Getu et al., 2025).

Selain itu, integritas profesional juga berkaitan dengan tanggung jawab moral bidan terhadap pasien, profesi, dan masyarakat. Bidan yang memiliki integritas akan berusaha menjaga standar praktik yang tinggi serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien maupun merusak reputasi profesi kebidanan (Salehin, 2025). Dengan demikian, integritas dalam praktik kebidanan tidak hanya mencerminkan kualitas pribadi seorang bidan, tetapi juga merupakan komponen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi kebidanan.

Integritas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kebidanan, integritas berfungsi sebagai dasar moral yang memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh bidan selalu berorientasi pada kepentingan terbaik pasien. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai etika profesional dapat meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat (Shahabnia et al., 2020). Integritas membantu tenaga kesehatan untuk mempertahankan komitmen profesional dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Dalam praktik kebidanan, integritas juga berkaitan dengan kepercayaan antara bidan dan pasien. Hubungan terapeutik antara bidan dan pasien dibangun atas dasar kepercayaan. Pasien mempercayakan kesehatan dirinya dan bayinya kepada bidan, sehingga bidan harus menjaga kepercayaan tersebut dengan memberikan pelayanan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Penelitian mengenai etika profesi dalam kebidanan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap kode etik sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada masyarakat (Sohrabi et al., 2024). Bidan yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih konsisten dalam menerapkan prinsip etika profesi dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, integritas juga berperan dalam menjaga keselamatan pasien. Kesalahan dalam praktik kesehatan dapat terjadi apabila tenaga kesehatan tidak mematuhi standar profesional atau mengabaikan prinsip etika dalam pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, integritas menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan kesalahan medis serta peningkatan keselamatan pasien. Integritas juga berperan dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kompetensi teknis, tetapi juga mencakup sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan komitmen terhadap standar profesi. Dengan memiliki integritas yang tinggi, bidan dapat menjalankan praktik kebidanan secara profesional serta menjaga reputasi profesi di mata masyarakat.

Integritas dalam praktik kebidanan dapat dilihat dari berbagai dimensi yang mencerminkan perilaku profesional seorang bidan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain integritas moral, integritas profesional dan integritas dalam pengambilan keputusan klinis. Integritas moral berkaitan dengan kemampuan individu untuk mempertahankan nilai-nilai moral dalam berbagai situasi yang dihadapi dalam praktik profesional. Dalam praktik kebidanan, integritas moral tercermin dalam komitmen bidan untuk selalu bertindak sesuai dengan prinsip etika profesi, meskipun menghadapi tekanan dari lingkungan kerja atau situasi yang kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan integritas moral pada mahasiswa kebidanan merupakan bagian penting dari proses pendidikan profesional. Pendidikan etika dalam kebidanan membantu mahasiswa memahami nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktik pelayanan kesehatan (Kabirian et al., 2024).

Integritas profesional berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar profesi dan kode etik yang berlaku. Bidan yang memiliki integritas profesional akan menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi serta regulasi yang berlaku. Integritas profesional juga mencakup komitmen bidan untuk terus meningkatkan kompetensi melalui

pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Hal ini penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terus mengalami perubahan. Dalam praktik kebidanan, bidan sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat. Integritas dalam pengambilan keputusan klinis berarti bahwa bidan harus mempertimbangkan aspek medis, etika, dan hukum sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa bidan sering menghadapi berbagai dilema etika dalam praktik klinis yang berkaitan dengan konflik antara nilai profesional, nilai budaya, dan kebijakan institusi kesehatan (Getu et al., 2025). Oleh karena itu, integritas menjadi sangat penting dalam membantu bidan menentukan keputusan yang paling tepat dalam situasi tersebut. Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan sering menghadapi berbagai dilema etika yang memerlukan pertimbangan moral yang kompleks. Dilema etika terjadi ketika seorang tenaga kesehatan harus memilih antara dua atau lebih pilihan yang masing-masing memiliki konsekuensi moral tertentu.

Penelitian menunjukkan bahwa bidan sering menghadapi dilema etika dalam praktik klinis yang berkaitan dengan berbagai faktor, seperti konflik antara nilai profesional dengan nilai budaya masyarakat, keterbatasan sumber daya kesehatan, serta kebijakan institusi kesehatan (Getu et al., 2025). Misalnya, dalam beberapa kasus, bidan mungkin menghadapi situasi di mana keputusan medis yang paling tepat secara klinis tidak sejalan dengan kepercayaan atau nilai budaya pasien. Dalam situasi seperti ini, bidan harus mampu menyeimbangkan antara prinsip etika profesional dengan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya pasien.

Integritas memainkan peran penting dalam membantu bidan menghadapi dilema etika tersebut. Bidan yang memiliki integritas akan berusaha mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan situasi tersebut serta mengambil keputusan yang paling sesuai dengan prinsip etika dan kepentingan terbaik pasien. Selain itu, integritas juga membantu bidan dalam menjaga profesionalisme ketika menghadapi tekanan dari lingkungan kerja. Dalam beberapa situasi, bidan mungkin menghadapi tekanan untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar profesional. Dalam situasi seperti ini, integritas membantu bidan untuk tetap mempertahankan prinsip etika dalam praktik profesional.

Penguatan integritas dalam profesi kebidanan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya melalui pendidikan etika profesi. Pendidikan etika merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan kebidanan yang bertujuan untuk membentuk karakter profesional mahasiswa kebidanan. Penelitian

menunjukkan bahwa pendidikan etika yang efektif dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa kebidanan terhadap prinsip-prinsip etika profesi serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi dilema etika dalam praktik klinis (Megregian et al., 2021). Selain melalui pendidikan formal, penguatan integritas juga dapat dilakukan melalui pembinaan profesional di lingkungan kerja. Organisasi profesi dan institusi kesehatan memiliki peran penting dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung penerapan nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam praktik pelayanan kesehatan.

Pelatihan etika profesional juga terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik profesi. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi pendidikan etika dapat meningkatkan tingkat kepatuhan bidan terhadap prinsip-prinsip kode etik dalam praktik pelayanan kesehatan (Shahabnia et al., 2020). Selain itu, penguatan integritas juga dapat dilakukan melalui pengembangan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam praktik pelayanan kesehatan. Sistem ini membantu memastikan bahwa tenaga kesehatan menjalankan praktik sesuai dengan standar profesional serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

C. Kejujuran dalam Pelayanan Kebidanan

Kejujuran merupakan salah satu nilai fundamental dalam etika profesi kesehatan, termasuk dalam praktik kebidanan. Kejujuran berkaitan dengan keterbukaan, transparansi, dan kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada pasien, keluarga pasien, serta kepada sesama tenaga kesehatan. Dalam praktik pelayanan kesehatan, kejujuran merupakan bagian penting dari hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien yang didasarkan pada rasa saling percaya (O'Connor et al., 2010). Dalam praktik kebidanan, kejujuran menjadi landasan utama dalam memberikan pelayanan yang etis dan profesional. Bidan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pasien mengenai kondisi kesehatan, prosedur medis, risiko yang mungkin terjadi, serta pilihan tindakan yang tersedia. Keterbukaan informasi ini penting agar pasien dapat membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan kesehatannya (Hall et al., 2012).

Kejujuran juga berkaitan dengan prinsip veracity dalam etika kesehatan. Prinsip veracity menekankan kewajiban tenaga kesehatan untuk menyampaikan kebenaran kepada pasien. Prinsip ini merupakan bagian penting dari etika profesional karena pasien memiliki hak untuk mengetahui kondisi kesehatannya secara jelas dan benar (Zolkefli, 2018). Selain itu, kejujuran dalam praktik kebidanan tidak hanya berkaitan dengan komunikasi kepada pasien, tetapi juga berkaitan dengan dokumentasi

medis, pelaporan klinis, serta komunikasi dengan tim kesehatan lainnya. Dokumentasi medis yang jujur dan akurat sangat penting untuk memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan serta untuk menghindari kesalahan medis yang dapat membahayakan pasien (Levett-Jones & Reid-Searl, 2022). Dengan demikian, kejujuran dalam praktik kebidanan merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga profesionalisme tenaga kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Hubungan terapeutik merupakan hubungan profesional antara tenaga kesehatan dan pasien yang didasarkan pada rasa saling percaya, penghormatan, serta komunikasi yang efektif. Dalam praktik kebidanan, hubungan terapeutik memiliki peran yang sangat penting karena pelayanan kebidanan melibatkan interaksi yang intens antara bidan dan pasien selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas.

Kejujuran merupakan salah satu elemen utama dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka antara tenaga kesehatan dan pasien dapat meningkatkan kepercayaan pasien serta meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima (Lyndon et al., 2011). Dalam praktik kebidanan, kejujuran juga berperan dalam meningkatkan partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan kesehatannya. Ketika pasien mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi kesehatannya, mereka dapat memahami pilihan perawatan yang tersedia serta risiko dan manfaat dari setiap pilihan tersebut.

Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan klinis serta meningkatkan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien (Entwistle et al., 2010). Oleh karena itu, kejujuran dalam komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan kebidanan yang berpusat pada pasien. Selain itu, kejujuran juga berperan dalam mencegah terjadinya konflik antara tenaga kesehatan dan pasien. Ketika pasien merasa bahwa tenaga kesehatan menyembunyikan informasi atau tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai kondisi kesehatannya, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan serta meningkatkan risiko terjadinya konflik dalam pelayanan kesehatan.

Salah satu aspek penting dari kejujuran dalam praktik kebidanan adalah keterbukaan dalam penyampaian informasi medis kepada pasien. Dalam pelayanan kesehatan modern, pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kondisi kesehatannya serta tindakan medis yang akan dilakukan. Proses penyampaian informasi ini sering disebut sebagai *informed consent*, yaitu proses di mana pasien diberikan informasi yang cukup mengenai prosedur medis sehingga

mereka dapat memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela. Informed consent merupakan salah satu prinsip penting dalam etika kesehatan yang menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien (Beauchamp & Childress, 1994). Dalam praktik kebidanan, informed consent sangat penting karena berbagai prosedur medis yang dilakukan selama kehamilan dan persalinan memiliki risiko tertentu. Oleh karena itu, bidan harus memastikan bahwa pasien memahami prosedur yang akan dilakukan serta risiko dan manfaat yang terkait dengan prosedur tersebut.

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dalam proses informed consent dapat meningkatkan pemahaman pasien terhadap prosedur medis serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima (Hall et al., 2012). Selain itu, kejujuran dalam penyampaian informasi medis juga mencakup kewajiban tenaga kesehatan untuk menyampaikan kesalahan medis apabila terjadi. Transparansi dalam pelaporan kesalahan medis merupakan bagian penting dari budaya keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan (Gallagher & Mazor, 2015).

Dokumentasi medis merupakan bagian penting dari praktik pelayanan kesehatan karena berfungsi sebagai catatan resmi mengenai kondisi pasien, tindakan medis yang dilakukan, serta hasil perawatan yang diberikan. Dokumentasi medis yang jujur dan akurat sangat penting untuk memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan serta untuk mencegah kesalahan medis. Dalam praktik kebidanan, dokumentasi medis mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan, proses persalinan, perawatan bayi baru lahir, serta pelayanan kesehatan reproduksi lainnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh bidan harus dicatat secara lengkap dan akurat dalam rekam medis pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi medis yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat meningkatkan risiko kesalahan medis serta dapat menimbulkan masalah hukum bagi tenaga kesehatan (Harrison et al., 2016). Oleh karena itu, kejujuran dalam dokumentasi medis merupakan salah satu aspek penting dari profesionalisme tenaga kesehatan. Selain itu, kejujuran dalam pelaporan klinis juga berkaitan dengan kewajiban tenaga kesehatan untuk melaporkan kejadian tidak diharapkan (*adverse events*) dalam pelayanan kesehatan. Pelaporan kejadian tidak diharapkan merupakan bagian penting dari sistem keselamatan pasien yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kesalahan medis serta untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama di masa depan.

Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan kesalahan medis dapat

meningkatkan keselamatan pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Mannion & Davies, 2018).

Meskipun kejujuran merupakan nilai yang sangat penting dalam praktik pelayanan kesehatan, penerapan nilai ini dalam praktik sehari-hari tidak selalu mudah. Tenaga kesehatan sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersikap jujur dalam praktik profesional. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah tekanan dari lingkungan kerja atau institusi kesehatan. Dalam beberapa situasi, tenaga kesehatan mungkin merasa tertekan untuk menyembunyikan kesalahan medis atau untuk tidak menyampaikan informasi yang sepenuhnya kepada pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi dapat menjadi hambatan dalam penerapan kejujuran dalam pelayanan kesehatan (Mannion & Davies, 2018). Oleh karena itu, penting bagi institusi kesehatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keterbukaan dan kejujuran dalam praktik pelayanan kesehatan. Selain itu, faktor budaya juga dapat mempengaruhi penerapan kejujuran dalam praktik kebidanan. Dalam beberapa budaya, penyampaian informasi mengenai kondisi kesehatan yang serius kepada pasien mungkin dianggap tidak sesuai atau bahkan dapat menimbulkan kecemasan bagi pasien. Dalam situasi seperti ini, tenaga kesehatan harus mampu menyeimbangkan antara prinsip kejujuran dengan sensitivitas budaya dalam komunikasi dengan pasien (Truog et al., 2011).

Untuk meningkatkan penerapan kejujuran dalam praktik kebidanan, diperlukan berbagai strategi yang melibatkan pendidikan, kebijakan organisasi, serta pengembangan budaya profesional dalam pelayanan kesehatan. Salah satu strategi yang penting adalah pendidikan etika dalam pendidikan kebidanan. Pendidikan etika membantu mahasiswa kebidanan memahami pentingnya nilai-nilai moral dalam praktik profesional serta mengembangkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai dilema etika dalam praktik klinis (Numminen et al., 2009). Selain itu, pelatihan komunikasi juga dapat membantu tenaga kesehatan meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi medis secara jujur dan efektif kepada pasien.

Institusi kesehatan juga memiliki peran penting dalam menciptakan budaya organisasi yang mendukung transparansi dan kejujuran dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem pelaporan kesalahan medis yang tidak bersifat menghukum serta melalui kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. Dengan demikian, penerapan kejujuran dalam praktik kebidanan tidak hanya bergantung pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga pada sistem organisasi dan budaya profesional dalam pelayanan kesehatan.

D. Tanggung Jawab Profesional Bidan

Tanggung jawab profesional merupakan salah satu prinsip utama dalam praktik profesi kesehatan, termasuk profesi kebidanan. Tanggung jawab profesional mengacu pada kewajiban moral, etika, dan hukum yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan kepada pasien, masyarakat, serta profesi itu sendiri. Dalam praktik kebidanan, tanggung jawab profesional menuntut bidan untuk memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Triviño-Juárez et al., 2016). Bidan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya dalam perawatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh bidan harus didasarkan pada standar profesi, kode etik, serta regulasi kesehatan yang berlaku.

Tanggung jawab profesional menuntut bidan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar praktik kebidanan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi maupun otoritas kesehatan (Renfrew et al., 2014). Tanggung jawab profesional juga berkaitan dengan komitmen tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien. Dalam pelayanan kesehatan modern, konsep patient-centered care menjadi salah satu prinsip penting dalam praktik pelayanan kesehatan. Konsep ini menekankan bahwa setiap keputusan klinis harus mempertimbangkan kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien (Gray, 2019). Selain itu, tanggung jawab profesional juga mencakup kewajiban bidan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam praktik pelayanan kesehatan. Hal ini berarti bahwa bidan harus mampu menjelaskan alasan medis maupun etika di balik setiap keputusan klinis yang diambil dalam praktik kebidanan (Neerland, 2018). Dengan demikian, tanggung jawab profesional dalam praktik kebidanan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban teknis dalam memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etika dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Tanggung jawab profesional bidan dapat dilihat dari beberapa dimensi yang saling berkaitan dalam praktik pelayanan kebidanan, antara lain tanggung jawab terhadap pasien, tanggung jawab terhadap profesi, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab utama seorang bidan adalah memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berkualitas kepada pasien. Dalam praktik kebidanan, bidan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta mencegah terjadinya komplikasi selama kehamilan dan persalinan.

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kebidanan sangat dipengaruhi oleh kompetensi profesional tenaga kesehatan serta kepatuhan terhadap standar praktik kebidanan yang telah ditetapkan (Ten Hoope-Bender et al., 2014). Oleh karena itu, bidan memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kompetensi profesional melalui pendidikan berkelanjutan. Selain itu, tanggung jawab terhadap pasien juga mencakup kewajiban bidan untuk menghormati hak-hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatan serta hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perawatan kesehatan.

Selain bertanggung jawab terhadap pasien, bidan juga memiliki tanggung jawab terhadap profesinya. Tanggung jawab ini berkaitan dengan kewajiban untuk menjaga reputasi profesi kebidanan serta memastikan bahwa praktik kebidanan dilakukan sesuai dengan standar profesional. Bidan harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesional seperti integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap aspek praktik kebidanan. Perilaku profesional yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi kebidanan (Mulowooza et al., 2021).

Selain itu, bidan juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pengembangan profesi melalui kegiatan penelitian, pendidikan, serta partisipasi dalam organisasi profesi. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga kesehatan dalam kegiatan profesional dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan (Homer et al., 2014). Bidan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Peran bidan dalam pelayanan kesehatan masyarakat sangat penting karena bidan sering menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap pelayanan kebidanan yang berkualitas dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi di berbagai negara (Campbell & Graham, 2006). Oleh karena itu, bidan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan kebidanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu, bidan juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, perawatan kehamilan, serta perawatan bayi baru lahir.

Tanggung jawab profesional juga mencakup kewajiban tenaga kesehatan untuk menjaga kesehatan dan kompetensi dirinya sendiri. Tenaga kesehatan yang tidak menjaga kesehatannya atau tidak memperbarui kompetensi profesionalnya berisiko memberikan pelayanan yang tidak optimal kepada pasien. Penelitian

menunjukkan bahwa kesejahteraan tenaga kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien (Hunter & Warren, 2014). Oleh karena itu, bidan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi agar dapat menjalankan praktik kebidanan secara optimal. Selain itu, bidan juga harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan profesional, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.

Selain tanggung jawab moral dan etika, bidan juga memiliki tanggung jawab hukum dalam praktik kebidanan. Tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban tenaga kesehatan untuk mematuhi regulasi kesehatan serta standar praktik profesional yang berlaku. Dalam banyak negara, praktik kebidanan diatur oleh berbagai regulasi kesehatan yang bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Pelanggaran terhadap regulasi tersebut dapat mengakibatkan sanksi administratif, sanksi profesional, maupun sanksi hukum (Gallagher & Mazor, 2015).

Tanggung jawab hukum juga berkaitan dengan kewajiban bidan untuk melakukan dokumentasi medis secara akurat serta menjaga kerahasiaan informasi pasien. Dokumentasi medis yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menimbulkan masalah hukum bagi tenaga kesehatan serta dapat membahayakan keselamatan pasien. Selain itu, bidan juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar praktik kebidanan yang berlaku. Apabila tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka tenaga kesehatan tersebut dapat dikenakan tuntutan hukum.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dari tanggung jawab profesional dalam praktik pelayanan kesehatan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban tenaga kesehatan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam praktik profesional. Dalam praktik kebidanan, akuntabilitas berarti bahwa bidan harus mampu menjelaskan alasan medis maupun etika di balik setiap keputusan klinis yang diambil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Penelitian menunjukkan bahwa sistem kesehatan yang memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi cenderung memiliki kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik serta tingkat keselamatan pasien yang lebih tinggi (Organization, 2021). Akuntabilitas juga berkaitan dengan transparansi dalam praktik pelayanan

kesehatan. Tenaga kesehatan harus bersikap terbuka terhadap evaluasi profesional serta bersedia menerima umpan balik mengenai kualitas pelayanan yang diberikan.

Penguatan tanggung jawab profesional dalam praktik kebidanan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pendidikan profesional, pengembangan sistem regulasi kesehatan, serta penguatan budaya profesional dalam pelayanan kesehatan. Pendidikan kebidanan memiliki peran penting dalam membentuk karakter profesional mahasiswa kebidanan. Kurikulum pendidikan kebidanan harus mencakup pendidikan etika profesi, hukum kesehatan, serta keselamatan pasien untuk memastikan bahwa lulusan memiliki pemahaman yang kuat mengenai tanggung jawab profesional dalam praktik kebidanan. Selain itu, organisasi profesi juga memiliki peran penting dalam menjaga standar profesional dalam praktik kebidanan. Organisasi profesi dapat menetapkan standar praktik kebidanan, memberikan pelatihan profesional, serta melakukan pengawasan terhadap praktik kebidanan.

Institusi kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung praktik profesional yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk menyediakan sumber daya yang memadai, mendukung pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, serta mengembangkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Dengan demikian, tanggung jawab profesional dalam praktik kebidanan tidak hanya bergantung pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga pada sistem pendidikan, regulasi kesehatan, serta budaya organisasi dalam pelayanan kesehatan.

E. Evaluasi Perilaku Profesional dan Penanganan Pelanggaran Etika dan Moral

Evaluasi perilaku profesional merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa tenaga kesehatan menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi serta kode etik yang berlaku. Dalam profesi kebidanan, perilaku profesional mencakup berbagai aspek seperti kompetensi klinis, komunikasi interpersonal, kepatuhan terhadap standar praktik, serta komitmen terhadap nilai-nilai etika profesi (O'Malley et al., 2019). Evaluasi perilaku profesional memiliki tujuan untuk memastikan bahwa bidan menjalankan praktik kebidanan secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran etika serta untuk mendorong perbaikan perilaku profesional dalam praktik kebidanan (Andrews et al., 2020).

Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, evaluasi profesional tidak hanya dilakukan untuk menilai kinerja tenaga kesehatan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa

sistem evaluasi profesional yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan keselamatan pasien (Clarke et al., 2007). Selain itu, evaluasi perilaku profesional juga memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kebidanan. Profesi kesehatan merupakan profesi yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap standar profesional atau kode etik dapat berdampak negatif terhadap reputasi profesi secara keseluruhan. Dengan adanya sistem evaluasi yang baik, organisasi profesi dan institusi kesehatan dapat memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan menjalankan praktik sesuai dengan nilai-nilai etika dan standar profesional yang telah ditetapkan.

Perilaku profesional dalam praktik kebidanan dapat dievaluasi melalui berbagai indikator yang mencerminkan sikap dan tindakan profesional seorang bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Salah satu indikator utama perilaku profesional adalah kompetensi klinis. Bidan harus memiliki kemampuan klinis yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan bayi secara aman dan efektif. Kompetensi klinis mencakup pengetahuan medis, keterampilan praktis, serta kemampuan dalam mengambil keputusan klinis yang tepat (Norris et al., 2020).

Indikator kedua adalah komunikasi profesional. Komunikasi yang efektif antara bidan dan pasien sangat penting dalam pelayanan kebidanan karena pelayanan ini melibatkan interaksi yang intens antara tenaga kesehatan dan pasien. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman pasien mengenai kondisi kesehatannya serta meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan (Watson et al., 2016). Indikator lain dari perilaku profesional adalah kepatuhan terhadap kode etik profesi. Bidan harus menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi, termasuk prinsip kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak pasien.

Selain itu, perilaku profesional juga mencakup kemampuan tenaga kesehatan dalam bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya. Dalam pelayanan kesehatan modern, kerja sama antarprofesi sangat penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi (Morley & Cashell, 2017). Dengan demikian, evaluasi perilaku profesional harus mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kompetensi teknis, sikap profesional, serta kemampuan interpersonal tenaga kesehatan.

Pelanggaran etika dalam praktik kebidanan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat berdampak negatif terhadap keselamatan pasien serta reputasi profesi kebidanan. Salah satu bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi dalam praktik kesehatan adalah pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan pasien. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien.

Pengungkapan informasi medis tanpa izin pasien dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika profesi serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum (Wiersma et al., 2018). Selain itu, pelanggaran etika juga dapat terjadi dalam bentuk ketidakjujuran dalam dokumentasi medis atau pelaporan klinis. Dokumentasi medis yang tidak akurat dapat membahayakan keselamatan pasien serta dapat menimbulkan masalah hukum bagi tenaga kesehatan.

Pelanggaran etika lainnya adalah penyalahgunaan kewenangan profesional. Misalnya, tenaga kesehatan menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi. Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam pelayanan kesehatan sering kali berkaitan dengan berbagai faktor seperti tekanan kerja, kurangnya pemahaman mengenai kode etik profesi, serta lemahnya sistem pengawasan dalam institusi kesehatan (Grace & Uveges, 2022).

Penanganan pelanggaran etika dalam praktik kebidanan merupakan tanggung jawab bersama antara organisasi profesi, institusi kesehatan, serta otoritas regulasi kesehatan. Mekanisme penanganan pelanggaran etika biasanya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari identifikasi pelanggaran hingga pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Tahap pertama dalam penanganan pelanggaran etika adalah proses investigasi atau penyelidikan. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai dugaan pelanggaran etika yang terjadi serta untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut benar-benar terjadi.

Tahap berikutnya adalah proses evaluasi profesional yang dilakukan oleh komite etik atau badan disiplin profesi. Komite ini bertugas untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melanggar kode etik profesi atau tidak. Apabila terbukti terjadi pelanggaran etika, maka tenaga kesehatan dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin praktik, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan (Wang et al., 2017). Penelitian menunjukkan bahwa sistem penanganan pelanggaran etika yang transparan dan adil dapat meningkatkan akuntabilitas dalam praktik pelayanan kesehatan serta membantu mencegah terjadinya pelanggaran etika di masa depan (Dekker, 2016).

Organisasi profesi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga standar profesional dalam praktik kebidanan. Organisasi profesi bertanggung jawab untuk menyusun kode etik profesi, menetapkan standar praktik kebidanan, serta melakukan pengawasan terhadap praktik kebidanan. Selain itu, organisasi profesi juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Penegakan kode etik merupakan salah satu cara untuk menjaga integritas profesi serta untuk memastikan

bahwa pelayanan kebidanan diberikan sesuai dengan standar profesional yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi profesi yang memiliki sistem pengawasan yang kuat dapat meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik profesi serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (MacVicar et al., 2017). Selain penegakan kode etik, upaya pencegahan pelanggaran etika juga merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan profesional dalam pelayanan kesehatan.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan etika dalam pendidikan kebidanan. Pendidikan etika membantu mahasiswa kebidanan memahami prinsip-prinsip etika profesi serta mengembangkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai dilema etika dalam praktik klinis (Hemberg & Bergdahl, 2020). Selain itu, institusi kesehatan juga perlu menciptakan budaya organisasi yang mendukung praktik profesional yang etis. Budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan transparansi dapat membantu tenaga kesehatan untuk melaporkan kesalahan medis serta untuk belajar dari kesalahan tersebut. Pelatihan profesional juga dapat membantu tenaga kesehatan meningkatkan pemahaman mereka mengenai kode etik profesi serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai situasi etika dalam praktik pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pencegahan pelanggaran etika tidak hanya bergantung pada penegakan disiplin profesi, tetapi juga pada upaya pengembangan profesional dan penguatan budaya etika dalam organisasi pelayanan kesehatan.

F. Simulasi / Roleplay Komunikasi Profesional Kebidanan

Dengan checklist Observasi dan Jurnal Refleksi

1. Tema

Komunikasi profesional bidan pada pelayanan ANC

2. Deskripsi kasus

Seorang ibu hamil usia 28 tahun datang ke puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan. Ibu mengeluhkan sering lelah dan tidak mau mengonsumsi tablet tambah darah karena menurut tetangga dapat menyebabkan bayi besar dan sulit melahirkan.

Mahasiswa yang berperan sebagai bidan diminta melakukan komunikasi profesional dengan memperhatikan:

- a. Evaluasi kepatuhan pada kode etik/standar perilaku
- b. Kinerja komunikasi profesional (empati, batas, konflik kepentingan)

3. Dialog

Pembukaan	
Mahasiswa	Selamat pagi ibu. Saya dengan rina, bidan yang akan bertugas hari ini. Apakah ada keluhan yang ibu rasakan?
Pasien	Saya sering merasa lemas bidan.
Pengkajian dan empati	
Mahasiswa	Saya memahami kondisi ibu pasti membut tidak nyaman. Apakah ibu rutin mengkonsumsi tablet peambah darah?
Pasien	Tidak bidan. Kata merua saya meminum itu bisa membuat bayi saya besar
Edukasi professional	
Mahasiswa	Terimakasih sudah menyampaikan kekhawatiran yang ibu rasakan. Tablet penambah darah merupakan suplemen yang berfungsi untuk menambahkadar hemoglobin pada darah yang bertujuan untuk mencegah anemia pada ibu saat hamil serta dapat membantu menjaga kesehatan ibu dan bayi selama dalam kandungan dan salah pemahaman jika dikaitkan dengan kondisi bayi ibu dapat menjadi besar. Besarnya bayi dalam kandungan tergantung dari asupan glukosa atau makanan maupun minuman dengan kadar gula /manis terlu banyak dikonsumsi oleh ibu saat masa kehamilannya.
Pasien	Oh begitu bu bidan, jadi pemaham saya selama ini tidak tepat.
Mahasiswa	Benar ibu, selama kehamilan ibu baiknya meminum 1 tablet per hari selama kehamilan. Diminum minimal 1 jam setelah makan.
Pasien	Baik bidan, saya akan meminum vitamn penambah darah sesuai yang disampaikan. terimakasih
Menjaga Batasan profesional	
Mahasiswa	Baik, terimakasih sudah dating hari ini ibu, semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk control sesuai jadwal ya.
Pasien	Baik, bidan terimakasih

G. Checklist Observasi Komunikasi Profesional

IDENTITAS MAHASISWA

NAMA :

NIM :

Hari/Tanggal :

NO	INDIKATOR PENILAIAN	YA	TDK	SKOR
	Evaluasi kepatuhan pada kode etik			
1	Memberi pelayanan pada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama dan status social pasien			
	Kinerja komunikasi profesional (empati, batas, konflik kepentingan)			
	Penampilan dan sikap professional			
2	Berpakaian rapih dan sopan			
3	Memberi salam dan memperkenalkan diri			
4	Menggunakan bahasa sopan dan profesional			
	EMPATI			
5	Mendengarkan pasien tanpa memotong pembicaraan			
6	Menunjukkan perhatian terhadap keluhan pasien			
7	Menggunakan kalimat empatik			
	BATAS PROFESIONAL			
8	Tidak menggunakan bahasa terlalu akrab/tidak pantas			
9	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien			
10	Memberikan informasi sesuai kewenangan bidan			
	TRANSPARANSI & ETIKA PROFESIONAL			
11	Tidak memaksakan pendapat pribadi			
12	Tidak menunjukkan konflik kepentingan			
13	Memberikan edukasi secara jujur dan objektif			
	KOMUNIKASI EFEKTIF			
14	Menjelaskan informasi dengan jelas			
15	Menutup komunikasi dengan baik			

PERHITUNGAN NILAI

Jumlah skor diperoleh = _____

Nilai akhir =

$$\frac{SORE\ DIPEROLEH}{SKOR\ MAKSIMAL} \times 100$$

H. Rubrik Penilaian Cpmk

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) – CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Evaluasi kepatuhan pada kode etik/standar perilaku	Tidak mampu mengenali pelanggaran; penilaian tidak berdasar	Mengenali sebagian pelanggaran; dasar rujukan masih umum	Mengenali pelanggaran utama; rujukan standar relevan dan tepat	Analisis sangat komprehensif; rujukan standar tepat dan menunjukkan pertimbangan integritas/tanggung jawab
3.2 Kinerja komunikasi profesional (empati, batas, konflik kepentingan)	Komunikasi tidak empatik/menyalahi batas; konflik kepentingan diabaikan	Komunikasi cukup empatik namun batas belum konsisten; konflik kepentingan belum jelas	Komunikasi empatik dan menjaga batas; konflik kepentingan dikelola dengan transparan	Komunikasi sangat efektif, sensitif konteks; batas profesional kuat; mitigasi konflik kepentingan jelas dan terdokumentasi

JURNAL REFLEKSI MAHASISWA

FORMAT REFLEKSI DIRI

IDENTITAS

NAMA :

NIM :

Hari/Tanggal :

Pengalaman selama simulasi

Tuliskan pengalaman yang diperoleh selama roleplay komunikasi profesional

Evaluasi Perilaku Profesional

a. Empati

Bagaimana Anda menunjukkan empati kepada pasien?

b. Batas professional

Bagaimana Anda menjaga hubungan profesional dengan pasien?

c. Transparansi dan etika

Bagaimana Anda menjaga kejujuran dan menghindari konflik kepentingan?

Kelebihan diri

Tuliskan kemampuan yang sudah baik selama simulasi.

Kekurangan diri

Tuliskan hal yang masih perlu diperbaiki.

rencana Perbaikan yang Spesifik

Tuliskan rencana perbaikan secara spesifik dan terukur.

I. Ringkasan

Bab ini membahas tentang kode etik bidan dan standar perilaku profesional yang menekankan pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam praktik kebidanan. Ketiga nilai tersebut merupakan landasan penting dalam membangun profesionalisme bidan serta menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan keluarga. Kode etik bidan merupakan seperangkat norma, nilai moral, dan prinsip etika yang disusun oleh organisasi profesi untuk menjadi pedoman perilaku bidan dalam menjalankan praktik kebidanan. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kebidanan dilakukan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab, serta melindungi hak dan keselamatan pasien. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai pedoman bagi bidan dalam menghadapi berbagai situasi etika yang mungkin muncul dalam praktik pelayanan kesehatan.

Integritas merupakan salah satu nilai utama dalam praktik kebidanan. Integritas mencerminkan konsistensi antara nilai moral, prinsip etika, dan tindakan profesional yang dilakukan oleh seorang bidan. Bidan yang memiliki integritas akan selalu bertindak sesuai dengan standar profesi, menjaga kepercayaan pasien, serta menempatkan kepentingan pasien sebagai prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Integritas juga berkaitan dengan komitmen bidan untuk menjalankan praktik kebidanan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Kejujuran merupakan bagian penting dari integritas profesional dalam praktik kebidanan. Kejujuran tercermin dalam keterbukaan bidan dalam menyampaikan informasi kepada pasien, keluarga pasien, serta kepada tim kesehatan lainnya.

Dalam pelayanan kebidanan, bidan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat mengenai kondisi kesehatan pasien, prosedur medis yang akan dilakukan, serta risiko dan manfaat dari setiap tindakan medis. Kejujuran dalam komunikasi sangat penting untuk membangun hubungan terapeutik yang baik antara bidan dan pasien serta untuk memastikan bahwa pasien dapat membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan kesehatannya.

Selain dalam komunikasi, kejujuran juga harus diterapkan dalam dokumentasi medis dan pelaporan klinis. Dokumentasi medis yang akurat dan jujur sangat penting untuk memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan serta untuk mencegah terjadinya kesalahan medis. Oleh karena itu, bidan harus mencatat setiap tindakan medis yang dilakukan secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Tanggung jawab profesional merupakan aspek penting lainnya dalam praktik kebidanan. Tanggung jawab profesional mencakup kewajiban bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar praktik kebidanan. Tanggung jawab ini tidak hanya ditujukan kepada pasien, tetapi juga kepada profesi, masyarakat, serta kepada diri sendiri sebagai tenaga kesehatan.

Tanggung jawab bidan terhadap pasien meliputi kewajiban untuk memberikan pelayanan yang aman dan bermutu, menghormati hak-hak pasien, menjaga kerahasiaan informasi medis, serta memberikan edukasi kesehatan yang diperlukan oleh pasien. Sementara itu, tanggung jawab terhadap profesi berkaitan dengan kewajiban bidan untuk menjaga reputasi profesi kebidanan, mematuhi kode etik profesi, serta terus meningkatkan kompetensi profesional melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

Bidan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Bidan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, edukasi kesehatan, serta dalam upaya pencegahan penyakit dan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Selain itu, bidan juga memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental serta terus mengembangkan kompetensi profesional. Tenaga kesehatan yang sehat dan kompeten akan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien.

Evaluasi perilaku profesional merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas praktik kebidanan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bidan menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kode etik profesi serta standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Evaluasi perilaku profesional dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penilaian kinerja, audit klinis, serta pengawasan oleh

organisasi profesi. Dalam praktik kebidanan, pelanggaran etika dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelanggaran kerahasiaan pasien, ketidakjujuran dalam dokumentasi medis, penyalahgunaan kewenangan profesional, atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar praktik kebidanan. Pelanggaran etika tersebut dapat berdampak negatif terhadap keselamatan pasien serta reputasi profesi kebidanan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanganan pelanggaran etika yang jelas dan transparan. Penanganan pelanggaran etika biasanya melibatkan proses investigasi, evaluasi oleh komite etik atau badan disiplin profesi, serta pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Organisasi profesi memiliki peran penting dalam menjaga standar profesional dalam praktik kebidanan. Organisasi profesi bertanggung jawab untuk menyusun kode etik, menetapkan standar praktik kebidanan, serta melakukan pengawasan terhadap praktik kebidanan. Selain itu, organisasi profesi juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Upaya pencegahan pelanggaran etika juga sangat penting dalam praktik kebidanan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan etika profesi, pelatihan profesional, serta pengembangan budaya organisasi yang mendukung praktik profesional yang etis dan bertanggung jawab. Dengan memahami dan menerapkan kode etik bidan serta standar perilaku profesional, diharapkan bidan dapat menjalankan praktik kebidanan secara profesional, berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kebidanan.

Glosarium

No	Glosarium	Pengertian
1	Akuntabilitas	Kewajiban seorang tenaga kesehatan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan profesional yang dilakukan kepada pasien, institusi kesehatan, organisasi profesi, dan masyarakat.
2	Autonomy (Otonomi)	Prinsip etika yang menekankan hak pasien untuk membuat keputusan secara mandiri mengenai perawatan kesehatannya setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas
3	Beneficence	Prinsip etika yang menekankan kewajiban tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat terbaik bagi pasien.

4	Confidentiality (Kerahasiaan)	Kewajiban tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan pasien atau alasan hukum yang sah.
5	Etika Profesi	Kumpulan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku bagi anggota suatu profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
6	Informed Consent	Persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah menerima penjelasan lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk manfaat, risiko, dan alternatif tindakan.
7	Integritas	Nilai moral yang mencerminkan konsistensi antara prinsip etika, nilai moral, dan tindakan profesional dalam praktik kebidanan.
8	Justice (Keadilan)	Prinsip etika yang menekankan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil tanpa diskriminasi.
9	Kode Etik Bidan	Seperangkat norma dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi bidan dalam menjalankan praktik kebidanan secara profesional dan bertanggung jawab.
10	Komunikasi Terapeutik	Proses komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien yang bertujuan untuk membangun hubungan saling percaya serta mendukung proses penyembuhan pasien.
11	Nonmaleficence	Prinsip etika yang menekankan kewajiban tenaga kesehatan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan pasien.
12	Pelanggaran Etika	Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi atau kode etik yang berlaku dalam suatu profesi.
13	Profesionalisme	Sikap dan perilaku yang mencerminkan kompetensi, integritas, tanggung jawab, serta komitmen terhadap standar profesi dalam menjalankan pekerjaan.
14	Rekam Medis	Dokumen yang berisi catatan mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, serta perkembangan kondisi pasien selama proses pelayanan kesehatan.
15	Standar Profesi	Pedoman yang berisi kriteria minimal mengenai kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang harus

		dimiliki oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesional.
16	Tanggung Jawab Profesional	Kewajiban moral, etika, dan hukum yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan.
17	Veracity	Prinsip etika yang menekankan kewajiban tenaga kesehatan untuk mengatakan kebenaran dan memberikan informasi yang jujur kepada pasien

J. Daftar Pustaka

- Andrews, C. J., Ellwood, D., Middleton, P. F., Homer, C. S. E., Reinebrant, H. E., Donnelly, N., Boyle, F. M., Gordon, A., Nicholl, M., Morris, J., Gardener, G., Davies-Tuck, M., Wallace, E. M., & Flenady, V. J. (2020). Survey of Australian maternity hospitals to inform development and implementation of a stillbirth prevention 'bundle of care.' *Women and Birth*, 33(3), 251–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2019.06.001>
- Ayesha Hendriana Ngestiningrum, Siska Diana Sari, Rizka, Taadi, Sofyan Wimbo agung Pradnyawan, Sigit Sapto Nugroho, & Dewi Iriani. (2020). A Midwife: Professional Ethics in Midwifery Practices, Managing Pregnancy and Childbirth Complications, and Legal Rights for Nursing Mothers. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(9), 262–269.
- Bakri, M. N. R. R., Al Hadi, Z. M., Haika, M. I., & Noupel, M. (2025). Legal Responsibility of Midwives in Handling Deliveries in Karyamulya Village. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(7), 322–335.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (1994). *Principles of biomedical ethics*. Edicoes Loyola.
- Campbell, O. M. R., & Graham, W. J. (2006). Strategies for reducing maternal mortality: getting on with what works. *The Lancet*, 368(9543), 1284–1299.
- Clarke, J. R., Lerner, J. C., & Marella, W. (2007). The role for leaders of health care organizations in patient safety. *American Journal of Medical Quality*, 22(5), 311–318.
- Dekker, S. (2016). *Just culture: Balancing safety and accountability*. crc Press.

- Entwistle, V. A., Carter, S. M., Cribb, A., & McCaffery, K. (2010). Supporting patient autonomy: the importance of clinician-patient relationships. *Journal of General Internal Medicine*, 25(7), 741–745.
- Gallagher, T. H., & Mazor, K. M. (2015). Taking complaints seriously: using the patient safety lens. In *BMJ quality & safety* (Vol. 24, Number 6, pp. 352–355). BMJ Publishing Group Ltd.
- Getu, T., Tega, A., Aragaw, G. M., Menesho, M. D., Demelash, R., Wale, H., & Addis, Z. (2025). Ethical dilemmas experienced by midwives in their professional practice in Northwestern Ethiopia: a phenomenological interview study. *BMC Medical Ethics*, 26(1), 102.
- Grace, P. J., & Uveges, M. K. (2022). *Nursing ethics and professional responsibility in advanced practice*. Jones & Bartlett Learning.
- Gray, M. (2019). How Australian dual registrants identified as midwives to meet national registration-renewal requirements. *Women and Birth*, 32(1), 50–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2018.05.006>
- Hall, D. E., Prochazka, A. V., & Fink, A. S. (2012). Informed consent for clinical treatment. *Cmaj*, 184(5), 533–540.
- Harrison, R., Walton, M., Healy, J., Smith-Merry, J., & Hobbs, C. (2016). Patient complaints about hospital services: applying a complaint taxonomy to analyse and respond to complaints. *International Journal for Quality in Health Care*, 28(2), 240–245.
- Hastuti, P., Winarso, S. P., & Yulian, D. R. (2022). STUDY OF THE HEALTH PROFESSIONAL CODE OF ETHICS BETWEEN EXPECTATIONS AND REALITY: CASE REVIEW ABSTRACT. *International Nursing Conference*, 1(1), 185–198.
- Hemberg, J., & Bergdahl, E. (2020). Dealing with ethical and existential issues at end of life through co-creation. *Nursing Ethics*, 27(4), 1012–1031. <https://doi.org/10.1177/0969733019874496>
- Homer, C. S. E., Friberg, I. K., Dias, M. A. B., ten Hoope-Bender, P., Sandall, J., Speciale, A. M., & Bartlett, L. A. (2014). The projected effect of scaling up midwifery. *The Lancet*, 384(9948), 1146–1157.
- Hunter, B., & Warren, L. (2014). Midwives' experiences of workplace resilience. *Midwifery*, 30(8), 926–934.

- Kabirian, M., Gooshki, E. S., & Khadivzadeh, T. (2024). The Process of Professional Ethics Development in Midwifery Students: A Grounded Theory Study. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 29(3), 302–308.
- Levett-Jones, T., & Reid-Searl, K. (2022). *The clinical placement-E-Book epub: an essential guide for nursing students*. Elsevier Health Sciences.
- Lyndon, A., Zlatnik, M. G., & Wachter, R. M. (2011). Effective physician-nurse communication: a patient safety essential for labor and delivery. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 205(2), 91–96.
- MacVicar, S., Berrang-Ford, L., Harper, S., Steele, V., Lwasa, S., Bambaiha, D. N., Twesigomwe, S., Asaasira, G., & Ross, N. (2017). How seasonality and weather affect perinatal health: Comparing the experiences of indigenous and non-indigenous mothers in Kanungu District, Uganda. *Social Science & Medicine*, 187, 39–48. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.06.021](https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.06.021)
- Mannion, R., & Davies, H. (2018). Understanding organisational culture for healthcare quality improvement. *Bmj*, 363.
- Megregian, M., Low, L. K., Emeis, C., de Vries, R., & Nieuwenhuijze, M. (2021). Essential components of midwifery ethics education: results of a Delphi study. *Midwifery*, 96, 102946.
- Morley, L., & Cashell, A. (2017). Collaboration in health care. *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, 48(2), 207–216.
- Mulowooza, J., Santos, N., Isabirye, N., Inhensiko, I., Sloan, N. L., Shah, S., Butrick, E., Waiswa, P., & Walker, D. (2021). Midwife-performed checklist and ultrasound to identify obstetric conditions at labour triage in Uganda: A quasi-experimental study. *Midwifery*, 96, 102949. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.102949](https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.102949)
- Neerland, C. E. (2018). Maternal Confidence for Physiologic Childbirth: A Concept Analysis. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 63(4), 425–435. <https://doi.org/10.1111/jmwh.12719>
- Norris, G., Martin, C. J. H., & Dickson, A. (2020). An exploratory Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) of childbearing women's perceptions of risk associated with having a high Body Mass Index (BMI). *Midwifery*, 89, 102789. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102789>

- Numminen, O., van der Arend, A., & Leino-Kilpi, H. (2009). Nurse educators' and nursing students' perspectives on teaching codes of ethics. *Nursing Ethics*, 16(1), 69–82.
- O'Connor, E., Coates, H. M., Yardley, I. E., & Wu, A. W. (2010). Disclosure of patient safety incidents: a comprehensive review. *International Journal for Quality in Health Care*, 22(5), 371–379.
- O'Malley, D., Smith, V., & Higgins, A. (2019). Women's solutioning and strategising in relation to their postpartum sexual health: A qualitative study. *Midwifery*, 77, 53–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.midw.2019.06.012>
- Organization, W. H. (2021). Global strategic directions for nursing and midwifery 2021–2025. World Health Organization.
- Rahayu, R., Faisal, R., Nuradli, N. K., & Fadillah, T. (2023). Pemublikasian Pasien Oleh Bidan Wayan Saat Praktek Persalinan Dalam Perspektif Etika Kebidanan Dan Psikologi. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., Silva, D. R. A. D., Downe, S., Kennedy, H. P., & McCormick, F. (2014). Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145.
- Salehin, S. (2025). Challenges and Considerations of Professional Ethics in Midwifery During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Content Analysis. *Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine*.
- Sari, J. M., & Solekah, U. (2025). Hubungan Pengetahuan Etika Profesi Terhadap Kepatuhan Hukum Kesehatan pada Alumni D3 Kebidanan STIKes Pondok Pesantren Assanadiyah yang Bekerja di Instansi Kesehatan Tahun 2025: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 6110–6116.
- Setianingsih, L. Z., Fathiyati, F., & Marbun, H. T. (2021). Gambaran Tingkat Pengetahuan Kode Etik Bidan dalam Penerapan Kewenangan Bidan Berdasarkan Permenkes No. 28 Tahun 2017 di Praktik Mandiri Bidan Wilayah Kerja Puskesmas Sobang Kabupaten Pandeglang Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Delima*, 3(2), 99–107.
- Shahabnia, S., Lotfi, R., Rahimzadeh, M., Yazdkhasti, M., & Tourzani, Z. M. (2020). Effects of counseling professional ethics principles on midwifery professional

codes of ethics compliance and applicability rate among midwives in community health centers: a randomized clinical trial in Iran. *The Pan African Medical Journal*, 35, 139.

Sohrabi, Z., Savabi-Esfahani, M., Shahriari, M., & Salehi, K. (2024). Observance of ethical codes of midwifery profession in students and graduates of department of midwifery and reproductive health, Isfahan University of Medical Sciences. *Journal of Education and Health Promotion*, 13(1), 434.

Ten Hoope-Bender, P., de Bernis, L., Campbell, J., Downe, S., Fauveau, V., Fogstad, H., Homer, C. S. E., Kennedy, H. P., Matthews, Z., & McFadden, A. (2014). Improvement of maternal and newborn health through midwifery. *The Lancet*, 384(9949), 1226–1235.

Triviño-Juárez, J. M., Nieto-Pereda, B., Romero-Ayuso, D., Arruti-Sevilla, B., Avilés-Gámez, B., Forjaz, M. J., Oliver-Barrecheguren, C., Mellizo-Díaz, S., Soto-Lucía, C., & Plá-Mestre, R. (2016). Quality of life of mothers at the sixth week and sixth month post partum and type of infant feeding. *Midwifery*, 34, 230–238.

Truog, R. D., Browning, D. M., Johnson, J. A., & Gallagher, T. H. (2011). Talking with patients and families about medical error: a guide for education and practice. JHU Press.

Wang, Y., Coiera, E., Runciman, W., & Magrabi, F. (2017). Using multiclass classification to automate the identification of patient safety incident reports by type and severity. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 17(1), 84.

Watson, B. M., Heatley, M. L., Gallois, C., & Kruske, S. (2016). The importance of effective communication in interprofessional practice: perspectives of maternity clinicians. *Health Communication*, 31(4), 400–407.

Wiersma, M., Kerridge, I., & Lipworth, W. (2018). Dangers of neglecting non-financial conflicts of interest in health and medicine. *Journal of Medical Ethics*, 44(5), 319–322. <https://doi.org/10.1136/medethics-2017-104530>

Yulianti, I. (2022). Peran penting mata kuliah etika profesi kebidanan terhadap perilaku etis mahasiswa kebidanan di Universitas Borneo Tarakan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(2).

Zhou, B., Zhu, Z., Ransom, B. R., & Tong, X. (2021). Oligodendrocyte lineage cells and depression. *Molecular Psychiatry*, 26(1), 103–117. <https://doi.org/10.1038/s41380-020-00930-0>

Zolkefli, Y. (2018). The ethics of truth-telling in health-care settings. *The Malaysian Journal of Medical Sciences: MJMS*, 25(3), 135.

BAB 2

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR PROFESI KEBIDANAN: MUTU, KESELAMATAN PASIEN, DAN AKUNTABILITAS

Tabel Capaian Pembelajaran Mahasiswa

Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
5.1 Menganalisis komponen standar pelayanan/profesi dan indikator mutu–keselamatan pasien.	5.2 Menilai kesesuaian praktik terhadap standar serta merumuskan rekomendasi peningkatan akuntabilitas.	CPMK-7 Merancang strategi mutu dan keselamatan pasien melalui manajemen risiko, pelaporan insiden/RCA, pencegahan malpraktik, kolaborasi/rujukan, serta integritas penelitian dan pengembangan profesional.	CPMK-4 Menafsirkan regulasi dan standar terkait kewenangan, perizinan, serta ruang lingkup praktik untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas pelayanan. CPMK-1 Menganalisis landasan etik, hukum, dan profesionalisme serta keterkaitannya dalam praktik pelayanan kebidanan/kesehatan di Indonesia.

Uraian Materi

Pelayanan kebidanan modern berada dalam konteks sistem kesehatan yang semakin kompleks, ditandai dengan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas, keselamatan pasien, dan akuntabilitas layanan. Transformasi pelayanan kesehatan tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pasien. Dalam paradigma pelayanan modern, bidan tidak hanya berperan sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan kebidanan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang harus mampu mengintegrasikan aspek klinis, etik, hukum, mutu, dan manajemen risiko.

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2021), keselamatan pasien merupakan komponen utama dalam mutu pelayanan kesehatan. WHO juga menegaskan bahwa sebagian besar insiden keselamatan pasien dapat dicegah melalui penerapan standar pelayanan yang baik, komunikasi efektif, serta budaya keselamatan dalam organisasi pelayanan kesehatan.

Di Indonesia, praktik kebidanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa pelayanan kebidanan harus dilakukan secara profesional, sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan kode etik profesi. Dengan demikian, pemahaman terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan akuntabilitas menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki oleh bidan.

A. Konsep Standar dalam Praktik Kebidanan

1. Pengertian Standar Profesi

Standar profesi adalah batas kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam menjalankan praktik kebidanan secara aman dan bertanggung jawab. Standar profesi mencakup kompetensi klinis, komunikasi, etik, manajerial, serta kolaboratif.

Menurut *International Confederation of Midwives* (ICM, 2021), profesi bidan harus berorientasi pada *woman-centered care*, *continuity of care*, dan *evidence-based practice*.

2. Komponen Standar Profesi

a. Kompetensi Klinis

Kemampuan bidan dalam melakukan asuhan kebidanan sesuai standar praktik.

b. Kompetensi Etik

Kemampuan menerapkan prinsip etik, meliputi *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*.

c. Kompetensi Komunikasi

Kemampuan membangun komunikasi terapeutik dengan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain.

d. Kompetensi Profesional

Meliputi tanggung jawab, integritas, akuntabilitas, serta pengembangan profesional berkelanjutan.

3. Evidence-Based Midwifery

Konsep evidence-based midwifery mengintegrasikan evidence (hasil penelitian ilmiah), clinical expertise (pengalaman klinis bidan), dan patient preference (nilai serta pilihan pasien). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan klinis didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia.

4. Standar sebagai Sistem Dinamis

Standar pelayanan kesehatan bersifat dinamis karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan kebutuhan pasien yang terus berubah. Oleh karena itu, bidan harus memiliki kemampuan critical appraisal dan lifelong learning.

B. Standar Pelayanan Kebidanan

1. Pendekatan Donabedian (Input-Proses-Output-Outcome)

Menurut Donabedian (1988), mutu pelayanan kesehatan terdiri atas struktur, proses, dan outcome.

a. Input

Meliputi tenaga kesehatan, sarana prasarana, fasilitas, dan kebijakan.

b. Proses

Meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi asuhan kebidanan.

c. Output

Pelayanan kebidanan yang diberikan kepada pasien.

d. Outcome

Status kesehatan ibu, bayi, dan kepuasan pasien.

2. Implementasi Standar dalam Praktik

Implementasi standar dalam praktik kebidanan meliputi penggunaan partograf, pencegahan infeksi, serta standar penanganan komplikasi obstetri.

3. Sistem Rujukan dan Keselamatan

Sistem rujukan yang baik harus tepat waktu, tepat indikasi, dan terkoordinasi. Kegagalan rujukan sering terjadi akibat:

- Keterlambatan pengambilan keputusan
- Kurangnya fasilitas transportasi

- Keterbatasan fasilitas rujukan

C. Standar Profesi Kebidanan

1. Kompetensi Profesional

Kompetensi bidan meliputi kompetensi klinis, komunikasi, etik, dan manajerial.

Kompetensi Bidan

Berdasarkan UU Kesehatan:

- a. Asuhan kebidanan
- b. Promosi kesehatan
- c. Deteksi komplikasi
- d. Kolaborasi

Etika Profesi

Empat prinsip etik:

- a. Autonomy
- b. Beneficence
- c. Non-maleficence
- d. Justice

2. Profesionalisme dalam Praktik

Profesionalisme ditunjukkan melalui integritas, tanggung jawab, akuntabilitas, dan komitmen terhadap kualitas pelayanan.

3. Dilema Etik dalam Kebidanan

Bidan harus mampu mengidentifikasi konflik nilai, menerapkan prinsip etik, dan mengambil keputusan profesional.

Contoh dilema:

- a. Pasien menolak tindakan medis
- b. Konflik antara keluarga dan pasien
- c. Keterbatasan fasilitas

D. Mutu Pelayanan Kebidanan

1. Pengertian Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan mampu memenuhi kebutuhan pasien secara optimal.

2. Dimensi Mutu Pelayanan

Dimensi mutu pelayanan meliputi *safety, effectiveness, efficiency, patient-centered care, timeliness*, dan *equity*.

3. Continuous Quality Improvement (CQI)

CQI merupakan proses peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui identifikasi masalah, analisis akar masalah, implementasi solusi, evaluasi hasil, dan standarisasi perbaikan.

4. Audit Klinis

Audit klinis digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik, mengidentifikasi gap pelayanan, dan meningkatkan mutu.

E. Keselamatan Pasien dalam Kebidanan

1. Konsep Patient Safety

Keselamatan pasien merupakan sistem untuk mencegah kesalahan pelayanan, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan keamanan pasien.

2. Human Error dan System Approach

Reason (2000) menjelaskan bahwa sebagian besar insiden keselamatan pasien disebabkan oleh kelemahan sistem.

3. Root Cause Analysis (RCA)

RCA merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi akar penyebab insiden keselamatan pasien.

Langkah RCA:

- a. Identifikasi insiden
- b. Pengumpulan data
- c. Analisis sebab
- d. Identifikasi akar masalah
- e. Rekomendasi

4. Budaya Keselamatan

Budaya keselamatan meliputi *no blame culture*, transparansi, dan pembelajaran organisasi.

F. Akuntabilitas dalam Praktik Kebidanan

1. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban tenaga kesehatan untuk mempertanggungjawabkan tindakan profesional secara etik, hukum, administratif, dan sosial.

2. Dokumentasi Klinis

Dokumentasi kebidanan harus lengkap, akurat, tepat waktu agar berfungsi sebagai bukti hukum, alat komunikasi, evaluasi mutu, dan sumber pendidikan.

3. Malpraktik

Malpraktik dapat terjadi akibat kelalaian, tindakan tidak sesuai standar, dan kurangnya kompetensi.

G. Integrasi Mutu, Keselamatan, dan Akuntabilitas

Komponen	Fungsi
Mutu	Menjamin kualitas pelayanan
Keselamatan Pasien	Melindungi pasien dari cedera
Akuntabilitas	Menjamin tanggung jawab profesional

H. Isu dan Tantangan Kontemporer

1. Tantangan Global

- Ketimpangan akses layanan
- Kualitas layanan tidak merata

2. Tantangan Nasional

- Distribusi tenaga kesehatan
- Infrastruktur terbatas

3. Transformasi Digital

- Rekam medis elektronik
- Artificial intelligence
- Telemedicine

I. Sintesis Akademik

Pelayanan kebidanan modern memerlukan integrasi antara *evidence-based practice*, *patient-centered care*, dan *risk management*.

J. Sistem Asesmen Pembelajaran

Pendekatan Asesmen

Asesmen pada Bab 2 menggunakan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang bertujuan mengukur ketercapaian:

- Sub-CPMK 5.1** → Analisis standar & indikator mutu–keselamatan
- Sub-CPMK 5.2** → Evaluasi praktik & rekomendasi akuntabilitas

Asesmen dilakukan melalui:

- Tes tertulis
- Analisis kasus
- Proyek berbasis sistem mutu dan keselamatan pasien

Tabel Sistem Asesmen Berbasis CPMK

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian	Bobot	Bukti/Produk
CPMK-1	Tes tertulis	Analisis etik dan profesionalisme	10%	Lembar jawaban
CPMK-4	Open-book regulasi	Kepatuhan praktik	15%	Checklist
CPMK-7	Proyek RCA dan CQI	Mutu dan keselamatan pasien	20%	Laporan proyek

K. Rubrik Penilaian

(Analisis Etik–Hukum–Profesionalisme)

Tabel Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Ketepatan konsep	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Analisis keterkaitan	Deskriptif	Sebagian	Logis	Kritis

Rubrik CPMK-4

(Regulasi dan Kepatuhan Praktik)

Tabel Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Interpretasi kewenangan	Salah	Sebagian tepat	Tepat	Sangat tepat & kontekstual
Rencana kepatuhan	Tidak ada	Kurang operasional	Jelas	Sistematis & preventif

Rubrik CPMK-7

(Mutu dan Keselamatan Pasien)

Tabel Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Identifikasi risiko	Tidak relevan	Sebagian	Relevan	Komprehensif & prioritas jelas
Kualitas RCA	Tidak tepat	Terbatas	Tepat	Sistemik & mendalam

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Rencana perbaikan	Tidak jelas	Kurang spesifik	Terukur	SMART & kolaboratif

Instrumen Penilaian

1. Ketepatan konsep
2. Analisis kasus
3. Identifikasi risiko
4. Kualitas RCA
5. Rencana perbaikan

Lembar Penilaian CPMK-1

Nama Mahasiswa: _____

1. Ketepatan konsep: ____ /4
2. Analisis kasus: ____ /4

Total: ____ /8

Lembar Penilaian CPMK-4

1. Interpretasi regulasi: ____ /4
2. Rencana kepatuhan: ____ /4

Total: ____ /8

Lembar Penilaian CPMK-7 (Proyek)

1. Identifikasi risiko: ____ /4
2. Kualitas RCA: ____ /4
3. Rencana perbaikan: ____ /4

Total: ____ /12

Evaluasi Pembelajaran (Bank Soal)

Pilihan Ganda

1. Prinsip utama keselamatan pasien adalah:
 - A. Efisiensi
 - B. Identifikasi pasien
 - C. Administrasi
 - D. Dokumentasi

Jawaban: B

Soal Esai

1. Jelaskan hubungan mutu pelayanan dengan keselamatan pasien dalam praktik kebidanan!
2. Analisis peran standar profesi dalam mencegah malpraktik.

L. Mini Kasus (HOTS)

Mini Kasus 1. Kesalahan Identifikasi Pasien

Seorang bidan memberikan antibiotik kepada pasien yang salah karena tidak melakukan identifikasi pasien sebelum tindakan.

Fokus Analisis

1. Identifikasi pelanggaran standar keselamatan pasien.
2. Analisis penyebab menggunakan RCA.
3. Susun rencana perbaikan berbasis CQI
4. Kaitkan aspek etik dan akuntabilitas hukum.

Mini Kasus

Standar Pelayanan dan Standar Profesi Kebidanan: Mutu, Keselamatan Pasien, dan Akuntabilitas

Mini kasus berikut disusun untuk membantu mahasiswa menganalisis penerapan standar pelayanan, standar profesi, keselamatan pasien, mutu pelayanan, serta akuntabilitas dalam praktik kebidanan. Kasus dapat digunakan untuk:

1. diskusi tutorial,
2. pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*),
3. OSCE,
4. maupun evaluasi HOTS berbasis CPMK.

Mini Kasus 1. Kesalahan Identifikasi Pasien

Kasus

Seorang bidan di ruang nifas memberikan obat antibiotik kepada pasien yang salah karena tidak melakukan identifikasi pasien sebelum tindakan. Pasien mengalami reaksi alergi ringan setelah pemberian obat.

Fokus Analisis

1. Identifikasi pelanggaran standar keselamatan pasien
2. Analisis penyebab insiden menggunakan RCA
3. Tentukan tindakan awal yang harus dilakukan bidan
4. Jelaskan aspek etik dan akuntabilitas kasus tersebut

Pembahasan Singkat

Kasus menunjukkan pelanggaran standar patient safety terutama pada:

1. identifikasi pasien,
2. komunikasi,
3. dan dokumentasi tindakan.

Faktor penyebab:

1. human error,
2. beban kerja,
3. dan tidak adanya double-check system.

Mini Kasus 2. Keterlambatan Rujukan Preeklampsia

Kasus

Ibu hamil usia 35 minggu datang ke praktik mandiri bidan dengan tekanan darah 170/110 mmHg, nyeri kepala berat, dan edema tungkai. Bidan hanya memberikan edukasi istirahat dan tidak segera merujuk pasien. Dua jam kemudian pasien mengalami kejang.

Fokus Analisis

1. Apakah tindakan bidan sesuai standar pelayanan?
2. Identifikasi tanda bahaya maternal
3. Jelaskan dampak keterlambatan rujukan
4. Susun rekomendasi peningkatan mutu pelayanan

Pembahasan Singkat

Kasus menunjukkan:

1. kegagalan deteksi dini,
2. keterlambatan keputusan rujukan,
3. dan risiko keselamatan maternal.

Mini Kasus 3. Dokumentasi Tidak Lengkap

Kasus

Seorang bidan melakukan pertolongan persalinan normal namun tidak mendokumentasikan hasil pemeriksaan kala IV secara lengkap. Setelah pasien pulang, terjadi perdarahan postpartum dan keluarga mempertanyakan tindakan bidan.

Fokus Analisis

1. Mengapa dokumentasi penting dalam praktik kebidanan?
2. Jelaskan hubungan dokumentasi dengan akuntabilitas hukum
3. Apa risiko jika dokumentasi tidak lengkap?

Pembahasan Singkat

Dokumentasi merupakan:

1. bukti hukum,
2. alat komunikasi,
3. dan bagian dari mutu pelayanan.

Dokumentasi yang tidak lengkap dapat meningkatkan risiko litigasi.

Mini Kasus 4. Pencegahan Infeksi Tidak Sesuai SOP

Kasus

Pada saat pertolongan persalinan, bidan tidak melakukan hand hygiene sesuai prosedur karena kondisi ruang bersalin yang sibuk. Tiga hari kemudian pasien mengalami infeksi puerperium.

Fokus Analisis

1. Identifikasi pelanggaran standar patient safety
2. Jelaskan hubungan hand hygiene dan mutu pelayanan
3. Analisis faktor sistem yang memengaruhi kejadian tersebut

Pembahasan Singkat

Kasus menunjukkan:

1. rendahnya budaya keselamatan pasien,
2. ketidakpatuhan SOP,
3. dan lemahnya sistem pengawasan mutu.

Mini Kasus 5. Pelanggaran Komunikasi Profesional

Kasus

Bidan menjelaskan kondisi komplikasi pasien di depan keluarga besar tanpa persetujuan pasien. Pasien merasa malu dan keberatan atas tindakan tersebut.

Fokus Analisis

1. Identifikasi pelanggaran etik pada kasus
2. Jelaskan prinsip autonomy dan confidentiality
3. Bagaimana komunikasi profesional yang benar?

Pembahasan Singkat

Kasus berkaitan dengan:

1. kerahasiaan pasien,
2. komunikasi terapeutik,
3. dan etik profesi kebidanan.

Mini Kasus 6. Partograf Tidak Digunakan

Kasus

Seorang ibu bersalin mengalami partus lama. Bidan tidak menggunakan partograf selama pemantauan persalinan. Bayi lahir dengan asfiksia ringan.

Fokus Analisis

1. Jelaskan fungsi partograf
2. Apakah tindakan bidan sesuai standar profesi?
3. Apa dampak terhadap keselamatan ibu dan bayi?

Pembahasan Singkat

Partograf merupakan alat penting untuk:

1. monitoring kemajuan persalinan,
2. deteksi dini komplikasi,
3. dan pengambilan keputusan rujukan.

Mini Kasus 7. Kesalahan Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan

Kasus

Pasien postpartum dengan anemia berat dirujuk ke rumah sakit. Namun, bidan tidak menyampaikan informasi kadar Hb terakhir kepada petugas rumah sakit sehingga terjadi keterlambatan transfusi.

Fokus Analisis

1. Jelaskan pentingnya komunikasi efektif dalam patient safety
2. Identifikasi risiko keselamatan pasien
3. Bagaimana prosedur handover yang benar?

Pembahasan Singkat

Komunikasi efektif merupakan salah satu sasaran utama keselamatan pasien.

Metode komunikasi yang dianjurkan:

- *SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation).*

Mini Kasus 8. Malpraktik karena Tindakan di Luar Wewenang

Kasus

Bidan melakukan tindakan vakum ekstraksi tanpa supervisi dokter dan tanpa indikasi yang jelas. Bayi lahir dengan trauma kepala ringan.

Fokus Analisis

1. Identifikasi pelanggaran kewenangan profesi
2. Jelaskan hubungan standar profesi dan malpraktik
3. Apa konsekuensi etik dan hukum kasus tersebut?

Pembahasan Singkat

Kasus menunjukkan:

1. tindakan di luar kewenangan,
2. pelanggaran standar profesi,
3. dan risiko tuntutan hukum.

Tabel Keterkaitan Mini Kasus dengan CPMK

Mini Kasus	CPMK Dominan	Fokus Pembelajaran
Identifikasi pasien	CPMK-7	Patient safety & RCA
Preeklampsia	CPMK-4	Standar pelayanan & rujukan
Dokumentasi	CPMK-1	Akuntabilitas hukum
Pencegahan infeksi	CPMK-7	Mutu & keselamatan
Kerahasiaan pasien	CPMK-1	Etik profesi
Partograf	CPMK-4	Kepatuhan SOP
Komunikasi SBAR	CPMK-7	Komunikasi efektif
Vakum ekstraksi	CPMK-4	Wewenang & malpraktik

Refleksi Pembelajaran

Mini kasus membantu mahasiswa mengembangkan:

1. kemampuan analisis klinis,
2. pengambilan keputusan profesional,
3. keterampilan patient safety,
4. serta integrasi etik, hukum, dan mutu pelayanan dalam praktik kebidanan.

Contoh Kasus Patologis Kebidanan dalam Mutu, Keselamatan Pasien, dan Akuntabilitas

Contoh kasus patologis kebidanan berikut disusun untuk membantu mahasiswa memahami penerapan standar pelayanan, keselamatan pasien, komunikasi profesional, dokumentasi, serta akuntabilitas praktik kebidanan pada kondisi klinis nyata. Setiap kasus dirancang berbasis pendekatan *patient safety* dan *evidence-based midwifery*.

Kasus 1. Perdarahan Postpartum karena Atonia Uteri

Deskripsi Kasus

Seorang perempuan usia 29 tahun G2P1A0 melahirkan spontan di Puskesmas. Setelah plasenta lahir, pasien mengalami perdarahan aktif ± 700 mL. Bidan terlambat melakukan manajemen aktif kala III dan tidak segera melakukan masase uterus. Tekanan darah pasien turun menjadi 90/60 mmHg dan pasien tampak pucat.

Analisis Klinis

Masalah Utama

- Perdarahan postpartum akibat atonia uteri

Faktor Risiko

- Multiparitas
- Kala III memanjang
- Kelelahan ibu

Standar yang Tidak Dipenuhi

Standar	Ketidaksesuaian
AMTSL	Tidak dilakukan optimal
Monitoring postpartum	Tidak adekuat
Dokumentasi	Tidak lengkap

Aspek Keselamatan Pasien

- Keterlambatan penanganan meningkatkan risiko syok hipovolemik
- Tidak ada komunikasi cepat untuk rujukan
- Tidak dilakukan identifikasi risiko sejak awal
-

Analisis RCA (Root Cause Analysis)

Faktor	Temuan
Human factor	Bidan terlambat mengenali atonia
System factor	SOP tidak dipatuhi
Communication factor	Tidak ada koordinasi tim
Environment factor	Keterbatasan alat emergensi

Tindakan Perbaikan (CQI)

1. Pelatihan AMTSL berkala
2. Audit maternal near miss
3. Simulasi kegawatdaruratan obstetri
4. Monitoring kepatuhan SOP

Kasus 2. Preeklampsia Berat dengan Keterlambatan Rujukan

Deskripsi Kasus

Ibu hamil usia 36 minggu datang ke BPM dengan keluhan nyeri kepala berat, pandangan kabur, dan edema ekstremitas bawah. Tekanan darah 170/110 mmHg. Bidan hanya memberikan istirahat tanpa melakukan rujukan segera. Dua jam kemudian pasien mengalami kejang.

Diagnosis

Preeklampsia berat berkembang menjadi eklampsia.

Analisis Standar Pelayanan

Komponen	Standar	Kondisi Kasus
Pemeriksaan tekanan darah	Dilakukan lengkap	Dilakukan
Identifikasi tanda bahaya	Harus segera	Terlambat
Sistem rujukan	Emergensi	Tidak segera

Aspek Etik dan Hukum

- Kelalaian dalam deteksi komplikasi
- Tidak sesuai standar praktik kebidanan
- Berpotensi menjadi kasus malpraktik

RCA

Penyebab	Penjelasan
Knowledge deficit	Bidan kurang memahami tanda bahaya
Delay decision	Keterlambatan keputusan rujukan
SOP issue	Tidak ada checklist emergensi

Rekomendasi

- Pelatihan deteksi dini preeklampsia

- Implementasi warning sign checklist
- Supervisi klinik berkala

Kasus 3. Sepsis Puerperalis akibat Pencegahan Infeksi Tidak Adekuat

Deskripsi Kasus

Pasien postpartum hari ke-4 datang dengan demam tinggi, nyeri abdomen, dan lochea berbau. Setelah dilakukan investigasi, diketahui prosedur pertolongan persalinan sebelumnya tidak memenuhi standar pencegahan infeksi.

Analisis Klinis

Diagnosis

Sepsis puerperalis.

Faktor Risiko

- Teknik aseptik tidak adekuat
- Sterilisasi alat tidak optimal
- Hand hygiene buruk

Standar Patient Safety yang Dilanggar

Sasaran Keselamatan Pasien	Ketidaksesuaian
Pencegahan infeksi	Tidak dilakukan optimal
Keselamatan prosedur	SOP tidak dipatuhi
Dokumentasi tindakan	Tidak lengkap

Analisis Mutu

Kasus menunjukkan rendahnya budaya keselamatan pasien (*safety culture*) dan lemahnya pengawasan mutu pelayanan.

Rencana CQI

1. Audit kepatuhan hand hygiene
2. Monitoring sterilisasi alat
3. Pelaporan insiden infeksi nosokomial

Kasus 4. Kesalahan Identifikasi Pasien pada Neonatus

Deskripsi Kasus

Dua bayi baru lahir ditempatkan dalam ruang perawatan yang sama. Gelang identitas salah dipasang sehingga terjadi kesalahan pemberian ASI donor kepada bayi lain.

Analisis Patient Safety

Komponen	Temuan
Identifikasi pasien	Tidak sesuai standar
Komunikasi tim	Lemah
Verifikasi tindakan	Tidak dilakukan

Dampak

- Risiko keselamatan neonatus
- Pelanggaran hak pasien
- Potensi tuntutan hukum

RCA

Human Error

- Kelalaian petugas

System Error

- Tidak ada double-check system

Strategi Pencegahan

- Barcode patient identification
- Double verification
- Checklist neonatal safety

Kasus 5. Ruptur Uteri akibat Keterlambatan Deteksi Partus Lama

Deskripsi Kasus

Ibu bersalin mengalami partus lama >18 jam. Bidan tidak menggunakan partograf secara optimal dan tidak melakukan rujukan tepat waktu. Pasien mengalami ruptur uteri dan fetal distress.

Analisis Standar

Standar	Pelanggaran
Penggunaan partograf	Tidak lengkap
Monitoring persalinan	Tidak adekuat
Rujukan	Terlambat

Aspek Akuntabilitas

Kasus menunjukkan:

- Kegagalan clinical judgment
- Ketidakpatuhan SOP
- Risiko litigasi

Pembelajaran Profesional

- Pentingnya partograf
- Pentingnya early warning system
- Pentingnya teamwork dan komunikasi

Tabel Ringkasan Kasus Patologis Kebidanan

Kasus	Masalah Utama	Risiko Keselamatan	Fokus Akuntabilitas
PPH	Atonia uteri	Syok hipovolemik	Kepatuhan SOP
Preeklampsia	Eklampsia	Kejang maternal	Rujukan

Kasus	Masalah Utama	Risiko Keselamatan	Fokus Akuntabilitas
Sepsis	Infeksi	Septic shock	Pencegahan infeksi
Identifikasi neonatus	Salah pasien	Kesalahan tindakan	Dokumentasi
Ruptur uteri	Partus lama	Kematian ibu/bayi	Monitoring

Tabel Refleksi OBE pada Kasus Patologis

CPMK	Implementasi pada Kasus
CPMK-1	Analisis etik dan profesionalisme
CPMK-4	Interpretasi regulasi dan standar
CPMK-7	RCA, CQI, patient safety, risk management

Kasus Patologis Kebidanan

Kasus 1. Perdarahan Postpartum karena Atonia Uteri

Deskripsi Kasus

Seorang perempuan usia 29 tahun mengalami perdarahan postpartum akibat keterlambatan manajemen aktif kala III.

Analisis RCA

Faktor	Temuan
Human factor	Keterlambatan deteksi
System factor	SOP tidak dipatuhi
Communication factor	Koordinasi tim kurang

Evaluasi OSCE

Tabel Blueprint Evaluasi OSCE

Komponen	Uraian
Topik	Patient safety dan akuntabilitas
Kompetensi	RCA, komunikasi, dokumentasi
Waktu	10–15 menit
Metode	Checklist OSCE

M. Ringkasan

Standar pelayanan dan standar profesi kebidanan merupakan fondasi utama dalam menjamin mutu, keselamatan pasien, dan akuntabilitas. Implementasi standar

yang konsisten, didukung budaya keselamatan dan sistem pelayanan yang baik, akan meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi kebidanan.

N. Daftar Pustaka

- Batalden, P. B., & Davidoff, F. (2007). What is quality improvement? *Quality and Safety in Health Care*, 16(1), 2–3.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? *JAMA*, 260(12), 1743–1748.
- Finn, R. (2024). Patient safety and healthcare quality improvement.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*.
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., Adeyi, O., Barker, P., Daelmans, B., Doubova, S. V., English, M., García-Elorrio, E., Guanais, F., Gureje, O., Hirschhorn, L. R., Jiang, L., Kelley, E., Lemango, E. T., Liljestrand, J., Malata, A., Marchant, T., Matsoso, M. P., Meara, J. G., Mohanan, M., Ndiaye, Y., Norheim, O. F., Reddy, K. S., Rowe, A. K., Salomon, J. A., Thapa, G., Twum-Danso, N. A. Y., & Pate, M. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: Time for a revolution. *The Lancet*, 392(10160), 2203–2212.
- Lazzerini, M., Argentini, G., Mariani, I., Covi, B., Semenzato, C., & Kaur, J. (2019). Implementation of the WHO standards to improve quality of maternal and newborn care in health facilities: A systematic review. *BMJ Open*, 9(8), e026307.
- Nurisnaini, N., et al. (2024). Mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- Percarpio, K. B., Watts, B. V., & Weeks, W. B. (2008). The effectiveness of root cause analysis: What does the literature tell us? *Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety*, 34(7), 391–398.

- Reason, J. (2000). Human error: Models and management. *BMJ*, 320(7237), 768–770.
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., Silva, D. R., Downe, S., Kennedy, H. P., Malata, A., McCormick, F., Wick, L., & Declercq, E. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145.
- Studdert, D. M., Mello, M. M., Gawande, A. A., Gandhi, T. K., Kachalia, A., Yoon, C., Puopolo, A. L., & Brennan, T. A. (2006). Claims, errors, and compensation payments in medical malpractice litigation. *New England Journal of Medicine*, 354(19), 2024–2033.
- Thaddeus, S., & Maine, D. (1994). Too far to walk: Maternal mortality in context. *Social Science & Medicine*, 38(8), 1091–1110.
- Topol, E. (2019). *Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again*. Basic Books.
- World Health Organization. (2016). *Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities*.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety report*.
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*.

BAB 3

INFORMED CONSENT DAN INFORMED CHOICE: PROSES, DOKUMENTASI DAN SITUASI KHUSUS

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, integritas, dan kepatuhan etika dalam praktik pelayanan kebidanan/ kesehatan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3; CPMK-6
CPL-2	Menerapkan hukum, regulasi, dan standar profesi untuk menjamin praktik yang sah, aman, dan akuntabel.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-3	Mengambil keputusan berbasis etika dengan mempertimbangkan hak pasien, keselamatan pasien, dan konteks sosial-budaya.	CPMK-2; CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan komunikasi profesional dan kolaborasi efektif dengan pasien/keluarga serta tim kesehatan, termasuk pengelolaan konflik kepentingan.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Menyelenggarakan dokumentasi dan pengelolaan informasi kesehatan secara akurat, aman, serta menjaga kerahasiaan dan privasi data.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melakukan refleksi, pembelajaran sepanjang hayat, pengembangan profesional berkelanjutan, serta menjunjung integritas ilmiah.	CPMK-3; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis landasan etik, hukum, dan profesionalisme serta keterkaitannya dalam praktik pelayanan kebidanan/ kesehatan di Indonesia.
CPMK-2	Menyusun keputusan pemecahan dilema etik berbasis prinsip dan nilai moral dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada kasus klinik.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Mengevaluasi perilaku profesional sesuai kode etik dan standar profesi, termasuk komunikasi, batas profesional, dan konflik kepentingan, serta merumuskan strategi perbaikan.
CPMK-4	Menafsirkan regulasi dan standar terkait kewenangan, perizinan, serta ruang lingkup praktik untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas pelayanan.
CPMK-5	Merancang dan mendokumentasikan proses informed consent/informed choice serta tindakan pada situasi khusus (termasuk kegawatdaruratan) sesuai ketentuan etik-hukum.
CPMK-6	Menerapkan prinsip kerahasiaan, privasi, dan perlindungan data pasien dalam pengelolaan rekam medis serta pertukaran informasi profesional.
CPMK-7	Merancang strategi mutu dan keselamatan pasien melalui manajemen risiko, pelaporan insiden/RCA, pencegahan malpraktik, kolaborasi/rujukan, serta integritas penelitian dan pengembangan profesional.

A. Pengertian Informed Consent dan Informed Choice

Hak asasi manusia bersifat tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, dan saling terkait, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2025). Pasien berhak atas otonomi dalam pelayanan kesehatan.

Perawatan yang memperhatikan, mendengarkan, dan memahami perempuan dikenal sebagai perawatan yang berpusat pada perempuan. Proses di mana bidan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuannya dijelaskan dalam "Teori Kemampuan Bidan." Hubungan antara bidan yang menciptakan ruang, momen waktu, dan kesetaraan dalam kekuasaan dan posisi membantu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini (Naughton S, Baldwin A, Harvey C, 2024).

Teori Kompetensi Kebidanan mengakui kesehatan, status sosial, dan kebebasan setiap wanita untuk menentukan nasibnya sendiri, yang sejalan dengan perspektif terkini dalam penyediaan layanan kebidanan. Selain meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, pendekatan ini menekankan kebutuhan masing-masing individu, yang meningkatkan keterlibatan melalui interaksi profesional yang autentik dan meningkatkan kepercayaan diri (Naughton S, Baldwin A, Harvey C, 2024).

Hak asasi manusia dan kapasitas saling terkait erat (Nussbaum, 2011). Hanya ketika seseorang memiliki kemampuan untuk bertindak, hak asasi manusianya dapat dijamin (Naughton, S. L., Harvey, C., & Baldwin, 2021). Pendekatan berbasis kompetensi melibatkan fokus pada kemampuan aktual individu, mengidentifikasi ketidakseimbangan, dan mengatasi ketidakseimbangan tersebut dengan memberikan kesempatan bagi kemampuan tersebut untuk diekspresikan (Naughton, S. L., Harvey, C., & Baldwin, 2021).

Kemampuan untuk menekankan otonomi pribadi dan pilihan sambil menyoroti perbedaan antara memaksakan nilai-nilai sendiri pada orang lain dan membiarkan mereka membuat keputusan sendiri (Nussbaum, 2011). Pemeliharaan perawatan yang berfokus pada kebutuhan individu, kesetaraan dalam hasil kesehatan, dan kualitas hidup didukung dalam layanan kebidanan melalui pemberdayaan perempuan, kemampuannya untuk menavigasi berbagai jalur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan (Naughton, S. L., Harvey, C., & Baldwin, 2021).

Bidan, manajer, dan tim eksekutif harus bekerja sama secara erat untuk menerapkan Komitmen Perawatan Wanita atau Perawatan Berpusat pada Wanita dalam layanan kebidanan. Hal ini memerlukan sikap saling menghormati,

pemahaman terhadap sudut pandang wanita, penyediaan informasi yang komprehensif sebelum pasien membuat keputusan, serta memastikan bahwa wanita merasa diperhatikan, didengarkan, dan dipahami oleh penyedia layanan kebidanan.

Karena tenaga medis tidak dapat menjamin kesembuhan pasien, *inspanningverbinten* (perjanjian upaya) mencakup perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Mereka menyediakan layanan medis dengan tujuan tulus untuk menyembuhkan pasien dengan menggunakan semua kemampuan dan keahlian mereka sesuai dengan norma profesional. Perjanjian terapeutik memiliki komponen tertentu. Dibandingkan dengan tenaga medis atau pekerja kesehatan lainnya, pasien berada dalam posisi yang lebih lemah karena mereka adalah pihak yang meminta bantuan. Hak pasien untuk memberikan persetujuan atas prosedur medis dikenal sebagai persetujuan yang terinformasi, dan hal ini telah dimasukkan sebagai prinsip untuk mengurangi kelemahan tersebut (Sunarto Adiwibowo, 2009).

Salah satu langkah penting untuk menghindari dilema etika adalah persetujuan yang didasarkan pada informasi. *Informed consent* dapat dipahami sebagai kesepakatan yang diberikan setelah memperoleh informasi, karena istilah ini berasal dari kata "*informed*" (telah menerima penjelasan, deskripsi, atau informasi) dan "*consent*" (memberikan persetujuan atau izin) (Purwoastuti, 2017).

Pengambilan keputusan setelah mendapatkan informasi tentang alternatif perawatan yang akan ditawarkan dikenal sebagai *informed choice* dalam layanan kebidanan. Tujuan utamanya adalah mendorong perempuan untuk membuat keputusan perawatan, dan tanggung jawab bidan tidak hanya terbatas pada memberikan perawatan; mereka juga harus memastikan bahwa hak dan keinginan perempuan dihormati (Anggraini, D. D., Aji, S. P., Fajriana, E., Kartikasari, N. D., & Sari, 2022).

Sebuah bentuk pemberdayaan pasien yang dikenal sebagai *informed choice* terjadi ketika bidan memberikan informasi kepada pasien tentang layanan medis. Bidan harus menghormati hak ibu untuk membuat *informed choice* dan meningkatkan penerimaan ibu terhadap pilihannya dalam perawatan serta tanggung jawabnya terhadap hasil dari pilihannya, demikian bunyi Kode Etik Bidan Internasional. Ibu diberikan informasi yang membantu mereka memahami konsekuensi potensial dari setiap keputusan, serta kelebihan dan kekurangannya. Sebagian besar wanita masih mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan, meskipun demikian, hal ini disebabkan oleh alasan-alasan sosioekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masalah ini juga diperparah oleh kurangnya pengetahuan tentang sistem kesehatan yang tersedia, batasan bahasa, dan pertimbangan lain (MacDonald, 2018).

Dari sudut pandang klien yang menerima layanan kebidanan, pilihan (*choice*) sangat penting karena memungkinkan mereka memahami sifat sebenarnya dari masalah tersebut dan menghormati hak mereka untuk otonomi dalam mengambil keputusan sendiri. Di sisi lain, persetujuan (*consent*) sangat penting bagi bidan karena merupakan dokumen hukum yang memberikan mereka hak untuk melakukan tindakan apa pun (Mildiana, 2023).

Penerapan *informed consent* sebagai wujud dari asas konsensualitas "*application of aspects of consent in medical procedures (informed consent) as a from of consensualism principle*" menyimpulkan bahwa prinsip hukum kesepakatan diterapkan melalui *informed consent* yang memadai, khususnya kesepakatan yang berfungsi sebagai penerapan prinsip konsensualisme, artinya kesepakatan dianggap telah dibuat setelah para pihak sepakat mengenai syarat-syarat esensialnya. "Semangat" dari "sikap tulus" dalam suatu perjanjian merupakan landasan konsensualisme. Pengakuan atas hak yang sama antara penyedia layanan kesehatan (tenaga medis/tenaga kesehatan) dan penerima layanan kesehatan (pasien) dikenal sebagai persetujuan yang didasarkan pada informasi yang memadai (Sunarto Adiwibowo, 2009).

B. Dasar Hukum Informed Consent

1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Paragraf 5 mulai Pasal 293-295 yang menjelaskan tentang Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023)
2. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat (4) syarat sahnya perjanjian agar mengikat secara hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, peraturan ini mengatur hak pasien atas informasi dan persetujuan tindakan medis, serta kewajiban dokter/fasilitas kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, 2008).
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2024 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dijelaskan pada Pasal 28 bahwa dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan berkewajiban antara lain untuk memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan serta meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan (PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2024).

Dimensi *informed consent* meliputi:

1. Dimensi hukum, yang melindungi baik pasien maupun bidan dari perilaku paksaan, mencakup keterbukaan informasi antara bidan dan pasien, informasi yang mudah dipahami oleh pasien, serta mendukung pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien.
2. Dimensi etik, yang merujuk pada nilai-nilai yang menghormati otonomi pasien, tidak melakukan intervensi kecuali diperlukan dan sesuai dengan informasi yang diberikan, serta bidan menilai pasien baik secara subjektif maupun berdasarkan pemikiran rasional (Busro, 2018).

Pemberi layanan kesehatan merasa lebih aman dalam menjalankan tugasnya ketika persetujuan tertulis dimasukkan ke dalam catatan medis. Dalam hal terjadi hasil yang tidak menguntungkan, persetujuan ini juga dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap gugatan atau klaim dari pasien atau keluarganya. Persetujuan pasien dalam hal ini memiliki definisi yang cukup luas, karena pasien dianggap telah diberi informasi dan telah memberikan wewenang kepada pemberi layanan kesehatan untuk bertindak secara tepat setelah menandatangani formulir persetujuan medis yang merupakan bagian dari catatan medis pasien (Febriyanti, Siti Nur Umariyah; Sari, 2025).

Untuk mencegah konflik di masa depan, bidan harus menghormati hak-hak klien mereka saat memberikan layanan kebidanan, terutama dengan memperoleh *informed consent* dan memungkinkan klien untuk membuat *informed choice* sebelum menerima layanan. Selain itu, hal ini memberikan bidan kerangka hukum untuk memberikan layanan kesehatan. Hal ini menjamin bahwa tidak ada yang dirugikan dan bahwa layanan komunitas memuaskan (Febriyanti, 2024).

C. Jenis, Fungsi dan Isi Informed Consent

Setiap tindakan kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapatkan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan. Persetujuan tertulis harus diperoleh sebelum melakukan tindakan invasif dan/atau berisiko tinggi. Persetujuan tertulis harus ditandatangani oleh pasien atau wakilnya dan disaksikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Persetujuan diberikan setelah pasien menerima penjelasan yang memadai mengenai hal-hal berikut:

1. Diagnosis
2. Indikasi
3. Prosedur medis yang dilakukan dan tujuannya
4. Bahaya dan masalah potensial
5. Metode alternatif dan bahaya yang ditimbulkannya
6. Bahaya jika tidak melakukan terapi

7. Prognosis setelah terapi (UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023).

Fungsi *informed consent* antara lain:

1. Menghormati nilai dan martabat pribadi pasien
2. Mengakui hak pasien untuk membuat keputusan sendiri
3. Kerahasiaan dan subjektivitas pasien
4. Mendorong tindakan medis untuk mempercepat proses penyembuhan
5. Memberikan peringatan saat memberikan perawatan medis untuk mencegah malpraktik
6. Mendorong pengambilan keputusan yang logis
7. Menghindari penipuan dan kecurangan
8. Melibatkan masyarakat umum dalam urusan kesehatan
9. Pendidikan publik di bidang hukum dan kesehatan
10. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (Busro, 2018)

Culver dan Gert menyatakan bahwa sukarela, informasi, kemampuan, dan pilihan adalah empat unsur *consent* atau persetujuan yang harus dipahami (Riyanti, S. S., & Keb, 2019).

Persetujuan yang didasarkan pada *informed consent* ketika pasien atau wali pasien telah menandatangani formulir persetujuan dan menerima penjelasan dari tenaga kesehatan sebelum kegiatan dilakukan. Hal ini memastikan bahwa tidak ada paksaan yang terlibat dalam pelaksanaan tindakan tersebut (Febriyanti, Siti Nur Umariyah; Sari, 2025) Untuk *informed consent* dapat diakui, pasien harus diberikan informasi yang jelas mengenai perawatan medis yang akan dilakukan pada mereka (Kristiawan, 2021) Salah satu hal yang perlu dilakukan bidan untuk mencegah konflik pengambilan keputusan adalah memberikan informasi yang akurat kepada ibu melalui media sosial, sebaiknya secara langsung. Materi ini harus jelas, jujur, dan mudah dipahami oleh klien (Riyanti, S. S., & Keb, 2019).

D. Langkah-langkah Standart Procedure Operational (SPO) Informed Consent

Wanita hamil harus membuat keputusan penting mengenai tempat dan cara melahirkan. Otonomi wanita harus dihormati, dan rencana persalinan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, sesuai dengan norma etika yang sangat kuat. Menghormati keputusan wanita selama kehamilan dan persalinan menghadapi beberapa hambatan praktis yang signifikan. Bagi wanita dan anak-anak mereka, serta mungkin bagi ibu dan tenaga medis, keputusan tersebut membawa risiko dan konsekuensi (Wilkinson D, Teli S, Litchfield C, 2025).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran disebut sebagai SPO *informed consent* dalam Kebidanan. Berikut langkah-langkah SPO *informed consent*.

1. Identifikasi dan Persiapan
 - a. Pasien diidentifikasi dengan akurat oleh bidan.
 - b. Membuat formulir persetujuan tindakan
2. Memberikan Informasi Terperinci

Bidan harus memberikan penjelasan verbal yang ringkas mengenai:

 - a. Diagnosis dan proses tindakan yang akan dilakukan oleh bidan.
 - b. Tujuan dan keuntungan tindakan tersebut.
 - c. Bahaya dan kesulitan yang mungkin timbul selama atau setelah tindakan.
 - d. Alternatif tindakan dan bahayanya.
 - e. Hasil yang diharapkan atau prognosis apakah tindakan dilakukan atau tidak.
3. Konfirmasi pemahaman
 - a. Pasien atau keluarga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada bidan.
 - b. Memastikan bahwa pasien menyadari semua konsekuensi dari pilihan tindakan yang dipilih secara bebas.
4. Penandatanganan dokumen
 - a. Jika pasien menyetujui, dokumen ditandatangani oleh wali atau kerabat terdekatnya, atau oleh pasien sendiri jika ia kompeten dan dewasa.
 - b. Formulir juga ditandatangani oleh bidan dan saksi, yang biasanya merupakan anggota keluarga atau tenaga medis lainnya.
5. Dokumentasi

Sebagai dokumen hukum, formulir yang ditandatangani harus disimpan dalam Rekam Medis Pasien (RMP).

Untuk memenuhi persyaratan layanan minimal, formulir persetujuan pengobatan harus diisi secara lengkap. Kelengkapan formulir persetujuan pengobatan memiliki konsekuensi hukum; jika tidak, pasien dapat mengalami cedera, reputasi rumah sakit dapat terganggu, dan tindakan hukum dapat diambil jika terjadi kesalahan identifikasi (Syamsul Bachri dkk, 2022). Penjelasan lengkap diberikan dalam bahasa yang sederhana atau dengan cara lain yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman, kemudian dicatat dan didokumentasikan dalam rekam medis, beserta nama, tanggal, waktu, dan tanda tangan dari orang yang memberikan dan menerima penjelasan.

E. Situasi Khusus dalam Informed Consent

Pasien yang bersangkutan memberikan persetujuan untuk terapi. Jika pasien yang bersangkutan tidak mampu memberikan persetujuan, seorang wakil dapat melakukannya atas namanya. Persetujuan untuk perawatan tidak diperlukan jika pasien tidak mampu dan membutuhkan perawatan darurat tetapi tidak ada yang

dapat memberikan persetujuan. Tenaga medis yang merawat pasien memutuskan apa yang terbaik bagi kepentingan pasien. Setelah pasien pulih atau wakilnya hadir, pasien diberitahu tentang perawatan tersebut. Fasilitas kesehatan juga wajib memberikan penjelasan kepada pasien mengenai biaya layanan yang mereka terima. Layanan kesehatan publik yang didanai pemerintah tidak memerlukan izin pengobatan, namun masyarakat yang dilayani tetap harus diberi informasi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023).

Pasien yang mampu atau anggota keluarga terdekat memberikan persetujuan. Sebelum prosedur dilakukan, kemampuan pasien mungkin dievaluasi. Pasien atau keluarganya dapat meminta persetujuan ulang jika mereka memiliki pertanyaan mengenai persetujuan yang telah diberikan. Dalam situasi khusus, persyaratan berikut berlaku:

1. Keluarga terdekat pasien harus memberikan persetujuan atas penghentian atau penolakan dukungan hidup pasien (*withdrawing/withholding life support*).
2. Setelah penjelasan dari tenaga medis, keluarga terdekat pasien dapat menyetujui penghentian atau penolakan dukungan hidup.
3. Persetujuan tertulis harus diberikan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, 2008).

Persetujuan tidak diperlukan untuk inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan umum. Setelah menerima penjelasan tertulis mengenai prosedur medis yang akan dilakukan, pasien dan/atau anggota keluarga terdekatnya berhak untuk menolaknya. Pasien bertanggung jawab atas konsekuensi dari penolakan tersebut, yang tidak mengakhiri hubungan dokter-pasien. Dokter atau dokter gigi yang memberikan terapi medis yang diresepkan, serta institusi kesehatan, bertanggung jawab (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, 2008).

F. Dokumentasi Informed Consent

Tenaga medis dan Tenaga kesehatan harus melakukan *informed consent* sebelum melakukan tindakan kepada pasien, terutama tindakan invasif. Berikut contoh surat persetujuan tindakan.

Surat Persetujuan Tindakan Kebidanan

I. PEMBERI INFORMASI

- **Nama Tenaga Kesehatan:** (Nama Bidan/Dokter)
- **Jenis Tindakan:** (Contoh: Persalinan Normal, Pemasangan IUD, dll)
- **Informasi yang diberikan:** (Diagnosis, dasar diagnosis, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, serta alternatif dan risiko jika tindakan tidak dilakukan).

II. PENERIMA INFORMASI / PEMBERI PERSETUJUAN

- **Nama Pasien/Keluarga:**
- **Tanggal Lahir / Umur:**
- **Alamat:**

III. PERNYATAAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- **Nama:**
- **Hubungan dengan Pasien:** (Diri sendiri / Suami / Orang tua / Wali)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima penjelasan secara lengkap mengenai tujuan, sifat, risiko, serta kemungkinan komplikasi dari tindakan (Sebutkan nama tindakan) yang akan dilakukan terhadap (Diri sendiri / Nama Pasien). Saya memahami sepenuhnya penjelasan tersebut dan memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan medis sesuai standar prosedur yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan.

(Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Yang Memberi Penjelasan Yang Membuat Pernyataan Saksi (Keluarga/Nakes)

(.....) (.....) (.....)

Rincian Penting untuk Mengisi Formulir:

1. Identitas Pasien: Kartu Pasien atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus sesuai.
2. Saksi: Seorang anggota keluarga dan seorang anggota staf medis sebaiknya menjadi dua saksi.
3. Kasus Darurat: Untuk perlindungan pasien, prosedur medis dapat dilakukan dalam situasi yang mengancam nyawa (seperti perdarahan parah) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya.
4. Arsip: Satu salinan asli harus disimpan dalam rekam medis pasien, dan satu salinan diberikan kepada pasien atau keluarga.

G. Latihan Kasus

Seorang perempuan, umur 35 tahun, melahirkan anak ke-3 di RS didampingi suami, dengan keluhan pusing setelah 30 menit plasenta lahir. Hasil Pemeriksaan: Ibu tampak pucat dan lemas, TD 90/50 mmHg, N 112x/menit, P 24x/menit, plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus lembek, perdarahan 550 cc. Bidan akan melakukan *informed consent* untuk dilakukan tindakan perdarahan postpartum (KBI dan KBE).

Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Keluhan pusing setelah 30 menit plasenta lahir
2. Ibu tampak pucat dan lemas
3. Tekanan darah 90/50 mmHg
4. Nadi 112x/menit
5. Pernafasan 24x/menit
6. Plasenta lahir lengkap
7. Kontraksi uterus lembek
8. Perdarahan 550 cc

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasikan tanda dan gejala yang menunjukkan adanya kondisi kegawatdaruratan masa nifas pada kasus di atas
2. Tentukan kemungkinan masalah atau diagnosis yang terjadi berdasarkan data pengkajian
3. Identifikasi faktor risiko yang dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi tersebut
4. Jelaskan asuhan kebidanan yang akan dilakukan pada kasus tersebut
5. Jelaskan jenis informasi apa saja yang harus dijelaskan pada saat melakukan *informed consent* sesuai kasus tersebut

H. Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	 (dikosongkan)
2	Judul	Nifas : <i>Informed consent/Informed choice</i> pada kasus perdarahan post partum yang akan dilakukan tindakan KBI/KBE
3	Kasus	Perdarahan post partum dengan pemberian <i>informed consent/informed choice</i> untuk tindakan KBI/KBE
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis identitas pasien 2. Diagnosis dan/atau masalah 3. Prosedur tindakan klinis (tujuan, prosedur tindakan, prognosis, risiko bila tindakan tidak dilakukan) 4. KIE/konseling 5. Kolaborasi 6. Perilaku profesional

No.	Komponen	Isi
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, umur 35 tahun, melahirkan anak ke-3 di RS didampingi suami, dengan keluhan pusing setelah 30 menit plasenta lahir. Hasil Pemeriksaan: Ibu tampak pucat dan lemas, TD 90/50 mmHg, N 112x/menit, P 24x/menit, plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus lembek, perdarahan 550 cc. Bidan akan melakukan <i>informed consent</i> untuk tindakan penanganan perdarahan postpartum (KBI dan KBE). TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan tindakan <i>informed consent/informed choice</i> terfokus sesuai kasus.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi-2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional-4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: • Actual mark (0/1/2/3) • Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan fisik, penguji memberikan data: Ibu tampak pucat dan lemas, TD 90/50

No.	Komponen	Isi
		mmHg, N 112x/menit, P 24x/menit, plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus lembek, perdarahan 550 cc. 3. Jika peserta meminta hasil anamnesis, penguji memberikan data : Seorang perempuan, umur 35 tahun, melahirkan anak ke-3 di RS didampingi suami, keluhan pusing setelah 30 menit plasenta lahir. 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas, melakukan tindakan <i>informed consent/informed choice</i>, memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapiakan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru <i>informed consent/informed choice</i> dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu nifas yang mengalami perdarahan post partum 2. PS tampak pucat dan lemas, mengeluh pusing setelah 30 menit plasenta lahir. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons secara kooperatif. 4. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dilakukan tindakan KBI/KBE, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Ibu dan Bapak. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan meminta persetujuan tindakan kepada ibu atau Bapak. Apakah ibu atau bapak bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya merasa pusing. Peserta: Sejak kapan merasa pusing? PS: Kira-kira setelah 30 menit plasenta (ari-ari) lahir, Bu. Peserta: Ibu dan Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata menunjukkan bahwa ibu mengalami perdarahan yang berlebihan setelah melahirkan (perdarahan postpartum), dan sebaiknya harus segera dilakukan tindakan penanganan. PS: Oh begitu, saya juga merasa sur-surur keluar darahnya Bu. Peserta: Iya Bu, Saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang kondisi Ibu dan rencana tindakannya, apabila Ibu atau Bapak sudah memahami dan menyetujui dilakukan tindakan, saya akan meminta bukti persetujuan dalam formulir ini sebagai dokumen persetujuan tindakan, apakah Ibu atau Bapak bersedia? PS: Iya, Bu. Peserta: Ibu dan Bapak, saat ini ibu mengalami perdarahan berlebihan selama melahirkan atau disebut perdarahan postpartum, penyebabnya adalah kontraksi rahim ibu yang kurang bagus setelah melahirkan atau lembek, sehingga membuat pembuluh darah rahim terbuka dan terjadilah perdarahan yang berlebihan setelah melahirkan, hasil anamnesis dan pemeriksaan yaitu ibu mengeluh pusing sejak 30 menit setelah ari-ari atau plasentanya lahir, ibu tampak pucat dan lemas, tekanan darah ibu juga mengalami kenaikan disertai naiknya nadi dan pernafasan ibu, perdarahan ibu sekitar 550 cc (lebih dari normal), rencana tindakan yang akan dilakukan dinamakan KBI/KBE yaitu bidan akan melakukan penekanan pada rahim dengan 1 tangan diletakkan di perut (di atas rahim) dan tangan lain masuk melalui jalan lahir ibu dan menekan mulut rahim, dilakukan penekanan selama beberapa menit untuk menghentikan perdarahan dan merangsang kontraksi rahim, selanjutnya akan dievaluasi perdarahan dan kontraksi rahimnya, apabila dibutuhkan akan dilakukan KBE dari luar rahim dibantu oleh suami ibu, dan diberikan pengobatan yang lainnya (memasang infus dan memberikan obat untuk merangsang

No.	Komponen	Isi
		kontraksi rahim/uterotonika). Tindakan tersebut sangat bermanfaat memperbaiki kontraksi ibu sehingga mengurangi perdarahan yang terjadi. Bapak dan Ibu jangan khawatir, kami akan berusaha membantu menangani perbaikan kontraksi rahim Ibu agar perdarahan segera bisa dikurangi. Apakah Ibu dan Bapak sudah memahami rencana tindakan tersebut dan bersedia menandatangani formulir persetujuan tindakan ini? Ataukah ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. PS: Iya Bu, kami sudah memahami rencana tindakan dan konsekuensinya, mohon dibantu agar perdarahannya segera berkurang. Peserta: Baik Ibu, sebelumnya saya akan bantu mengisikan formulir persetujuan tindakan dan meminta tanda tangan Ibu sebagai pasien dan Bapak sebagai saksi, Saya sebagai bidan yang akan menangani juga akan menandatangani formulir tersebut dan menyimpannya sebagai dokumentasi, selanjutnya kami akan segera melakukan tindakan sesuai prosedur, terima kasih. PS: Iya Bu, terima kasih. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom ibu
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar-lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Underpad — 1 3. Phantom ibu — 1 4. Lembar dokumentasi — 1 set 5. Formulir <i>informed consent/informed choice</i> — 1 lembar 6. Lembar jawaban peserta — 1 lembar

No.	Komponen	Isi
		7. Pena — 1
13	Penulis	Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T, MH
14	Referensi	Anggraini, D. D., Aji, S. P., Fajriana, E., Kartikasari, N. D., & Sari, L. P. (2022). <i>Etika Profesi Kebidanan</i>. Get Press. Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan. <i>Law, Development and Justice Review</i>, 1(1), 1–18. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570 Febriyanti, Siti Nur Umariyah; Sari, A. A. (2025). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Kesehatan. <i>Smart Law Journal</i>, 4(1), 35–46. https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/100 Febriyanti, S. N. U. dkk. (2024). <i>Etika Profesi dan Hukum Kesehatan</i>. PT Nuansa Fajar Cemerlang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kristiawan, A. P. (2021). Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien Di Rumah Sakit. <i>Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat</i>, 19(1). http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/2161 MacDonald, M. E. (2018). The making of informed choice in midwifery: a feminist experiment in care. <i>Culture, Medicine, and Psychiatry</i>, 42(2), 278–294. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11013-017-9560-9 Mildiana, Y. E. (2023). Hubungan Persepsi Supervisi Bidan Desa dengan Penerapan Informed Choice dan Informed Consent pada Pelayanan Kontrasepsi. <i>Jurnal Keperawatan</i>, 21(1), 87–102. https://doi.org/https://doi.org/10.35874/jkp.v21i1.1195 Naughton, S. L., Harvey, C., & Baldwin, A. (2021). Providing woman-centred care in complex pregnancy situations. <i>Midwifery</i>, 102, 103060. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103060 Naughton S, Baldwin A, Harvey C, C. T. (2024). The midwifery

No.	Komponen	Isi
		capabilities theory: How midwives enact woman-centered care to address systemic inequity. <i>Birth</i>, 52(3), 472–481. https://doi.org/doi:10.1111/birt.12866 Nussbaum, M. C. (2011). <i>Creating capabilities: The human development approach</i>. Harvard University Press. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pub. L. No. 290 (2008). Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2025). <i>Hari Hak Asasi Manusia 2025 - Pesan Sekretaris Jenderal, António Guterres</i>. https://indonesia.un.org/id/306737-hari-hak-asasi-manusia-2025-pesan-sekretaris-jenderal-ant%C3%B3nio-guterres PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 28 (2024). Purwoastuti, E. et al. (2017). <i>Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan</i>. Pustaka Baru Press. Riyanti, S. S., & Keb, M. (2019). <i>ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN</i>. Wenika Media. Sunarto Adiwibowo. (2009). <i>Hukum Kontrak Terapeutik di Indonesia</i>. Pustaka Bangsa Press. Syamsul Bachri dkk. (2022). Aspek Hukum Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent). <i>Jurnal Berita Kesehatan: Jurnal Kesehatan</i>, XV(2). https://ojs.stikes.gunungsari.id/index.php/GBK/article/view/96/90 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (2023). UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17 (2023). Wilkinson D, Teli S, Litchfield C, et al. (2025). Ethics round table: choice and autonomy in obstetrics. <i>Journal of Medical Ethics</i>, 51, 588–592. https://doi.org/https://doi.org/10.1136/jme-2024-110503

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase: Nifas: Informed Consent/Informed Choice pada kasus perdarahan post partum dengan tindakan KBI/KBE

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat persalinan sekarang (kapan partus)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **4** = Jika peserta ujian melakukan dengan tepat, lengkap dan sistematis.
- **3** = Jika peserta ujian melakukan dengan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- **2** = Jika peserta ujian melakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- **1** = Jika peserta ujian tidak melakukan

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menyampaikan hasil anamnesis dan pemeriksaan		
b. Menjelaskan diagnosa dan penyebabnya		
c. Menjelaskan rencana tindakan dan tujuannya		
d. Menjelaskan prosedur tindakan, alternatif dan konsekuensinya		
e. Menjelaskan prognosis tindakan		
f. Melakukan konfirmasi pemahaman atau <i>feedback</i>		
g. Menyiapkan formulir persetujuan tindakan (<i>Informed Consent</i>)		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
h. Meminta klien/pasien/wali, keluarga sebagai saksi, dan tenaga kesehatan untuk menandatangani formulir persetujuan tindakan		
i. Menyimpan formulir yang sudah diisi lengkap sebagai dokumentasi		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan formulir yang sudah diisi dan rencana lanjutan untuk tindakan		
b. Mencatat temuan penting pada catatan medis/form rujukan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **4** = Jika proses sangat baik, jelas, terstruktur, responsif, memastikan pemahaman dan pilihan secara optimal
- **3** = Jika informasi inti lengkap, pemahaman diverifikasi dan keputusan sukarela terfasilitasi
- **2** = Jika informasi inti tersampaikan sebagian dan verifikasi pemahaman terbatas
- **1** = Jika informasi inti tidak tersampaikan dan tidak melakukan verifikasi pemahaman kepada pasien/wali/keluarga

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan (tujuan, prosedur, prognosa dll)		
4. Menjelaskan perlunya persetujuan tindakan		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **4** = Jika peserta ujian melakukan dengan tepat, lengkap dan sistematis.
- **3** = Jika peserta ujian melakukan dengan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- **2** = Jika peserta ujian melakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap

- **1** = Jika peserta ujian tidak melakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **4** = Jika peserta ujian melakukan dengan tepat, lengkap dan sistematis.
- **3** = Jika peserta ujian melakukan dengan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- **2** = Jika peserta ujian melakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- **1** = Jika peserta ujian tidak melakukan

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

$$\text{TOTAL SKOR} = \text{jumlah skor kompetensi } \frac{1 + 2 + 3 + 4}{4}$$

(dicatat di rubrik penilaian)

IV.Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skor}}{31} \times 100 =$$

(Kota),

.....

Penguji:.....

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan post partum dengan pemberian <i>informed consent/informed choice</i> untuk tindakan KBI/KBE
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup <i>informed consent</i> , persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian <i>informed consent/informed choice</i> pada kasus perdarahan postpartum yang akan dilakukan KBI/KBE, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan <i>informed consent/informed choice</i> .
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan postnatal yang <i>evidence-based, woman-centered</i> .	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang nifas dengan perdarahan postpartum, tetapi juga kemampuannya menilai kondisi ibu, membaca data, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya identifikasi tanda bahaya dan pengambilan keputusan awal.	Seorang perempuan, umur 35 tahun, melahirkan anak ke-3 di RS didampingi suami, dengan keluhan pusing setelah 30 menit plasenta lahir. Hasil Pemeriksaan: Ibu tampak pucat dan lemas, TD 90/50 mmHg, N 112x/menit,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan post partum dengan pemberian <i>informed consent/informed choice</i> untuk tindakan KBI/KBE
		P 24x/menit, plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus lembek, perdarahan 550 cc. Bidan akan melakukan <i>informed consent</i> untuk tindakan penanganan perdarahan postpartum (KBI dan KBE).
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain memahami hasil anamnesis dan pemeriksaan serta melakukan <i>informed consent/informed choice</i> sebelum tindakan KBI/KBE sebagai penanganan perdarahan postpartum serta pencatatan sebagai keterampilan penting.	Mahasiswa memperkenalkan diri, menilai kondisi ibu, membaca tanda-tanda perdarahan postpartum, menjelaskan perlunya tindakan KBI/KBE segera, dan meminta persetujuan tindakan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan apabila diperlukan, rencana pasca tindakan, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali adanya tanda perdarahan postpartum antara lain perdarahan lebih dari normal (> 500 cc) dan kontraksi uterus kurang bagus/lembek, ibu merasa pusing, pucat dan lemas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan post partum dengan pemberian <i>informed consent/informed choice</i> untuk tindakan KBI/KBE
		sebagai tanda bahwa nifas tidak lagi aman.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada nifas, WHO menekankan identifikasi tanda bahaya atau kegawatdaruratan dan langkah penanganan yang efektif.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan mengenali tanda bahaya/kegawatdaruratan masa nifas, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, dan kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan post partum dengan pemberian <i>informed consent/informed choice</i> untuk tindakan KBI/KBE
		tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatdaruratan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level <i>does</i> karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus perdarahan postpartum, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan <i>informed consent/informed choice</i> serta tindakan awal kegawatdaruratan nifas secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

I. Tabel. Portofolio pada Informed Consent/Informed Choice kasus Perdarahan PostPartum yang akan dilakukan KBI/KBE

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan postpartum dengan pemberian informed consent/informed choice untuk tindakan KBI/KBE
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi	Pada topik Informed Consent/Informed Choice kasus perdarahan postpartum yang akan dilakukan KBI/KBE,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan postpartum dengan pemberian informed consent/informed choice untuk tindakan KBI/KBE
	mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian nifas dengan perdarahan postpartum, mengenali tanda bahaya/keawatdaruratan pada ibu nifas, melakukan tindakan informed consent/informed choice sebagai dasar melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan informed consent/informed choice sebagai dasar dalam menangani ibu nifas dengan perdarahan postpartum, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi profesional, pengenalan perdarahan postpartum pada masa nifas, dan tindakan awal berupa informed consent/informed choice. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu nifas, tindakan informed consent/informed choice, dan persiapan tindakan KBI/KBE.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan postpartum dengan pemberian informed consent/informed choice untuk tindakan KBI/KBE
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu Seorang perempuan, umur 35 tahun, melahirkan anak ke-3 di RS didampingi suami, dengan keluhan pusing setelah 30 menit plasenta lahir. Hasil Pemeriksaan: Ibu tampak pucat dan lemas, TD 90/50 mmHg, N 112x/menit, P 24x/menit, plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus lembek, perdarahan 550 cc. Bidan akan melakukan informed consent/informed choice sebagai dasar untuk tindakan penanganan perdarahan postpartum (KBI dan KBE).
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda tindakan informed consent/informed choice, ketelitian pemeriksaan, pemantauan perdarahan dan kontraksi uterus, pencegahan keterlambatan tindakan KBI/KBE, dan komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus perdarahan postpartum.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan informed consent/informed choice, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam memberikan berbagai informasi saat melakukan informed consent/informed choice

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan postpartum dengan pemberian informed consent/informed choice untuk tindakan KBI/KBE
		dan ketegasan saat melakukan eskalasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus informed consent/informed choice kegawatdaruratan seperti perdarahan postpartum, tetapi juga dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai adanya kebutuhan melakukan informed consent/informed choice dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan profesionalitasnya dalam mengenali tanda bahaya/kegawatdaruratan dan mengambil keputusan awal yang tepat pada setiap kasus yang bermasalah berupa informed consent/informed choice.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang	Pada topik perdarahan post partum dengan pemberian informed consent/informed choice untuk tindakan KBI/KBE, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan postpartum dengan pemberian informed consent/informed choice untuk tindakan KBI/KBE
	berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel. Case Report pada Kasus Perdarahan post partum dengan pemberian informed consent/informed choice untuk tindakan KBI/KBE

Komponen	Deskripsi	Perdarahan postpartum dengan pemberian <i>informed consent/informed choice</i> untuk tindakan KBI/KBE
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu nifas dengan perdarahan postpartum, merasa pusing, terlihat pucat dan lemas, tekanan darah turun, nadi dan pernapasan cepat, kontraksi uterus kurang bagus/lembek dan perdarahan lebih banyak dari normal yang akan dimintai persetujuan untuk tindakan KBI/KBE.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, prosedur <i>informed consent/informed choice</i> dan rencana tindakannya.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan ibu nifas 30 menit setelah plasenta lahir mengalami pusing, tampak pucat dan lemas, tekanan darah turun, nadi dan pernapasan naik, kontraksi uterus kurang bagus/lembek, perdarahan lebih dari normal dengan kecurigaan perdarahan postpartum dan tindakan awal stabilisasi,

Komponen	Deskripsi	Perdarahan postpartum dengan pemberian <i>informed consent/informed choice</i> untuk tindakan KBI/KBE
		<i>informed consent/informed choice</i> dan keputusan tindakan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menilai adanya kegawatdaruratan masa nifas, dan melakukan <i>informed consent/informed choice</i> dengan baik dan benar sebagai dasar penanganan selanjutnya.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan <i>clinical reasoning</i> , keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus perdarahan postpartum dengan pemberian <i>informed consent/informed choice</i> untuk tindakan KBI/KBE, mahasiswa belajar bahwa pemantauan ibu nifas, dan keputusan eskalasi dini merupakan inti keselamatan dalam asuhan nifas dengan perdarahan postpartum.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, <i>case report</i> menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep nifas dengan perdarahan postpartum yang membutuhkan <i>informed consent/informed choice</i> sebagai dasar tindakan KBI/KBE, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel. Refleksi Perdarahan postpartum dengan pemberian informed consent/informed choice untuk tindakan KBI/KBE

Komponen	Deskripsi	Perdarahan postpartum dengan pemberian <i>informed consent/informed choice</i> untuk tindakan KBI/KBE
Hakikat refleksi patient <i>safety</i>	Refleksi <i>patient safety</i> merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus perdarahan postpartum dengan pemberian <i>informed consent/informed choice</i> untuk tindakan KBI/KBE, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali perdarahan postpartum yang membutuhkan <i>informed consent/informed choice</i> yang baik dan benar sehingga memberi pemahaman yang baik kepada pasien dan keluarga sebagai dasar tindakan selanjutnya dapat menyebabkan perburukan kondisi ibu.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah menentukan diagnosa, tidak memantau kontraksi dan perdarahan, atau menunda <i>informed consent/informed choice</i> dapat berdampak besar pada keselamatan ibu.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah syok hipovolemik dan kematian.

Komponen	Deskripsi	Perdarahan postpartum dengan pemberian <i>informed consent/informed choice</i> untuk tindakan KBI/KBE
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis, keterlambatan mengenali tanda perdarahan postpartum, keterlambatan dilakukan <i>informed consent/informed choice</i> dan keterlambatan tindakan KBI/KBE.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan prosedur tindakan <i>informed consent/informed choice</i> dan komunikasi cepat kepada keluarga sebagai dasar tindakan selanjutnya untuk mencegah terjadinya masalah pada pasien.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada masa nifas memungkinkan untuk terjadi kegawatdaruratan, sehingga deteksi dini, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

J. Ringkasan

Bab ini menekankan bahwa *informed consent* harus dilakukan oleh tenaga medis/tenaga kesehatan, khususnya bidan, sebelum melakukan tindakan, terutama tindakan kegawatan dan invasif, agar terhindar dari tuntutan hukum di kemudian hari apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Informasi yang diberikan saat melakukan *informed consent* harus lengkap dan bisa dipahami oleh pasien/wali/keluarga sehingga tujuan tercapai, yaitu pasien menyetujui tindakan yang akan dilakukan. Pasien berhak melakukan *informed choice* setelah dilakukan *informed consent* dengan benar oleh bidan. Dokumentasi *informed consent* harus dilengkapi oleh pemberi *informed consent* serta dibubuhi tanda tangan pasien/walinya, keluarga, atau tenaga medis/tenaga kesehatan lain sebagai saksi, dan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan *informed consent*.

Mahasiswa perlu memahami bahwa tindakan *informed consent/informed choice* sangat diperlukan. Informasi yang diberikan meliputi diagnosis, indikasi, prosedur medis yang dilakukan dan tujuannya, bahaya dan masalah potensial, metode alternatif dan bahaya yang ditimbulkannya, bahaya jika tidak melakukan terapi dan prognosis setelah terapi.

Langkah-langkah SPO *informed consent* meliputi identifikasi dan persiapan, pemberian informasi secara terperinci, konfirmasi pemahaman, penandatanganan dokumen dan dokumentasi. Berdasarkan persetujuan tindakan yang tercantum dalam formulir persetujuan tindakan, maka tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan memiliki kepastian hukum.

Informed consent/informed choice dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh klien atau pasien, secara dua arah, sangat diperlukan *feedback* dengan pasien untuk mengecek pemahamannya tentang tindakan yang akan dilakukan yang berdampak pada pemberian persetujuan atau penolakan tindakan.

Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep *Informed consent/informed choice* tetapi juga harus memahami semua tindakan kebidanan yang akan dilakukan, untuk selanjutnya diinformasikan kepada klien atau pasien secara lengkap dan jelas. Klien atau pasien akan memahami konsekuensi pilihannya dengan baik dan tidak menyesal di kemudian hari.

Glosarium

Episiotomi: prosedur medis berupa sayatan kecil pada perineum (area antara lubang vagina dan anus) yang dilakukan selama proses persalinan normal karena suatu indikasi medis tertentu seperti bayi besar, persalinan dengan vacum dan sebagainya.

Forceps: alat medis berbentuk seperti dua sendok besar atau penjepit yang digunakan dokter untuk membantu mengeluarkan bayi melalui vagina saat persalinan macet, ibu kelelahan mengejan, atau gawat janin.

Prognosis: prediksi atau perkiraan tenaga medis atau tenaga kesehatan mengenai perkembangan, jalannya penyakit, dan kemungkinan hasil akhir (seperti kesembuhan, komplikasi, atau tingkat kelangsungan hidup) berdasarkan kondisi medis pasien saat ini. Prognosis berbeda dengan diagnosis, karena merupakan proyeksi ke depan yang didasarkan pada pengalaman medis, data ilmiah, dan respons terhadap pengobatan.

Tindakan invasif: prosedur medis yang masuk atau menembus ke dalam tubuh, seperti melalui kulit atau selaput lendir menggunakan jarum, endoskop, atau alat bedah, seperti operasi, biopsi, atau pemasangan kateter.

Ekstraksi vakum: prosedur persalinan normal (pervaginam) yang dibantu dengan alat khusus berupa cangkir hisap (vacuum extractor) yang ditempelkan di kepala bayi.

K. Daftar Pustaka

- Anggraini, D. D., Aji, S. P., Fajriana, E., Kartikasari, N. D., & Sari, L. P. (2022). *Etika Profesi Kebidanan*. Get Press.
- Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>
- Febriyanti, Siti Nur Umariyah; Sari, A. A. (2025). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Kesehatan. *Smart Law Journal*, 4(1), 35–46. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/100>
- Febriyanti, S. N. U. dkk. (2024). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kristiawan, A. P. (2021). Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(1).

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/2161>

- MacDonald, M. E. (2018). The making of informed choice in midwifery: a feminist experiment in care. *Culture, Medicine, and Psychiatry*, 42(2), 278–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11013-017-9560-9>
- Mildiana, Y. E. (2023). Hubungan Persepsi Supervisi Bidan Desa dengan Penerapan Informed Choice dan Informed Consent pada Pelayanan Kontrasepsi. *Jurnal Keperawatan*, 21(1), 87–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.35874/jkp.v21i1.1195>
- Naughton, S. L., Harvey, C., & Baldwin, A. (2021). Providing woman-centred care in complex pregnancy situations. *Midwifery*, 102, 103060. *Midwifery*, 102. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103060>
- Naughton S, Baldwin A, Harvey C, C. T. (2024). The midwifery capabilities theory: How midwives enact woman-centered care to address systemic inequity. *Birth*, 52(3), 472–481. <https://doi.org/doi:10.1111/birt.12866>
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pub. L. No. 290 (2008).
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2025). *Hari Hak Asasi Manusia 2025 - Pesan Sekretaris Jenderal, António Guterres*. <https://indonesia.un.org/id/306737-hari-hak-asasi-manusia-2025-pesan-sekretaris-jenderal-ant%C3%B3nio-guterres>
- PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 28 (2024).
- Purwoastuti, E. et al. (2017). *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Pustaka Baru Press.
- Riyanti, S. S., & Keb, M. (2019). *ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN*. Wenika Media.
- Sunarto Adiwibowo. (2009). *Hukum Kontrak Terapeutik di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press.
- Syamsul Bachri dkk. (2022). Aspek Hukum Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent). *Jurnal Berita Kesehatan: Jurnal Kesehatan*, XV(2). <https://ojs.stikes.gunungsari.id/index.php/GBK/article/view/96/90>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (2023).

UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17 (2023).

Wilkinson D, Teli S, Litchfield C, et al. (2025). Ethics round table: choice and autonomy in obstetrics. *Journal of Medical Ethics*, 51, 588–592. <https://doi.org/https://doi.org/10.1136/jme-2024-110503>

PROFIL PENULIS



Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH. Penulis Lahir di Semarang, 14 Februari 1980, menyelesaikan studi DIII Kebidanan AKBID Depkes Semarang tahun 2001, D IV Bidan Pendidik STIKES Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2003, AKTA Mengajar Universitas PGRI Semarang tahun 2006, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang tahun 2015, Profesi Bidan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta tahun 2022. Pernah bekerja sebagai Bidan di TPMB dan RSIA Bunda Semarang tahun 2001-2003, aktif di beberapa organisasi baik sebagai anggota atau pengurus organisasi seperti Pengurus IBI Cabang Kota Semarang, DPW Jateng MHKI (Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia), Ikatan Alumni Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan beberapa organisasi lain di masyarakat, bekerja sebagai Dosen di Universitas Karya Husada Semarang mulai tahun 2003-sekarang. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat rutin dipublikasikan oleh penulis tiap semester di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Prosiding baik nasional maupun internasional. Beberapa modul dan buku referensi sudah dipublikasikan, ber-ISBN dan mendapat HKI antara lain Buku Ajar Natural Basic Therapy IV, Modul Inovasi Pijat Bayi Prematur dengan Music Lullaby, Buku Saku Olahan Buah Pisang dan Alpukat untuk Meningkatkan Berat Badan Balita Gizi Kurang, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan Fisiologis, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Persalinan dan BBL Fisiologis, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Nifas Fisiologis, Buku Sukses UKOM D III Bidan 2023, Buku Pencegahan Penyakit dan Stimulasi Perkembangan Pada Anak, Buku Referensi Asuhan Kebidanan dan Keperawatan Pada Kasus Patologi Kehamilan, Buku Asuhan Kebidanan Kasus Patologis Pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah, Buku Etika dan Hukum Kesehatan, Buku Panduan Lulus Ukom Profesi Bidan II, Buku Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Buku Sistem Perlindungan Anak di Indonesia, Buku Brain Gym dan Ketrampilan Menggunting Sebagai Stimulasi Perkembangan Motorik Halus Pada Balita, Buku Etika dan Hukum Dalam Rekam Medis, Buku Pencegahan Anemia Pada Remaja Putri, Buku Referensi Deteksi Dini Pada Kehamilan Dari Perkembangan Janin hingga Persiapan Kelahiran. Penulis dapat dihubungi melalui email febriyanti@stikesyahoedsmg.ac.id dengan nomor telepon 085 6269 3401.



Dida Wanti, S.Tr.Keb., SKM., M.H(Kes) Lahir di Karawang, 07 Mei 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan pada Tahun 2009, S1 Kesehatan Masyarakat Tahun 2011, S2 Hukum Kesehatan Tahun 2014, melanjutkan profesi kebidanan Tahun 2018. Penulis mengawali karier pada bidang praktisi kebidanan baik di RUmah sakit, Klinik, Puskesmas dan BPM sejak 2010-2018 dan kini berkarier dibidang akademisi. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap pada Prodi D3 Kebidanan di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar pada ruang lingkup hukum Kesehatan dan kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: didawanti07@gmail.com Motto: "Education is the most powerful weapon to change the world"

PROFIL PENULIS



Intan Rina Susilawati, SST., Bdn., M.Keb., lahir di Garut pada tahun 1976. Saat ini, bekerja sebagai Dosen di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, Institut Kesehatan Karsa Husada Garut sejak tahun 2011 hingga sekarang.

Dengan latar belakang pendidikan dalam bidang kebidanan. Anak bungsu dari empat bersaudara dan berhasil menyelesaikan studi Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2018. Pada tahun 1995 lulus dari Program Pendidikan Bidan Depkes Bandung sebagai Bidan PTT dan ditugaskan menjadi Bidan Desa di

Kabupaten Garut. Mengabdikan sebagai bidan desa selama 6 tahun dari tahun 1995 sampai tahun 2001. Kemudian mengabdikan sebagai bidan praktik swasta murni sampai tahun 2017.

Saat sekarang, selain menjalankan tugas akademik sebagai dosen juga menjabat sebagai Kepala UPT Binkesmas di tempatnya bekerja, sebelumnya pernah menjabat Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, aktif dalam organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia sebagai Pengurus Cabang Kabupaten Garut sejak tahun 2008 sampai tahun 2025 di Bidang Organisasi. Memiliki pengalaman dalam publikasi jurnal ilmiah, buku serta telah berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan seminar nasional melalui telekonferensi. Dedikasi dan kontribusinya dalam bidang kebidanan, terutama dalam aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terus menjadi motivasi dalam pengembangan keilmuannya.

Sinopsis

Buku Ajar Etik, Hukum, dan Profesionalisme Praktik Kebidanan di Indonesia membahas dasar-dasar etik, hukum, dan sikap profesional yang harus dimiliki bidan dalam menjalankan praktik kebidanan. Buku ini memuat materi tentang prinsip etik, kode etik bidan, hak dan kewajiban bidan serta pasien, kewenangan praktik, informed consent, kerahasiaan pasien, dokumentasi, keselamatan pasien, dan tanggung jawab hukum dalam pelayanan kebidanan.

Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami pentingnya memberikan pelayanan yang aman, bermutu, beretika, legal, dan bertanggung jawab. Dengan penyajian yang sistematis, buku ini diharapkan menjadi bekal bagi calon bidan dalam menghadapi berbagai situasi praktik kebidanan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Buku Ajar Etik, Hukum, dan Profesionalisme Praktik Kebidanan di Indonesia membahas dasar-dasar etik, hukum, dan sikap profesional yang harus dimiliki bidan dalam menjalankan praktik kebidanan. Buku ini memuat materi tentang prinsip etik, kode etik bidan, hak dan kewajiban bidan serta pasien, kewenangan praktik, informed consent, kerahasiaan pasien, dokumentasi, keselamatan pasien, dan tanggung jawab hukum dalam pelayanan kebidanan.

Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami pentingnya memberikan pelayanan yang aman, bermutu, beretika, legal, dan bertanggung jawab. Dengan penyajian yang sistematis, buku ini diharapkan menjadi bekal bagi calon bidan dalam menghadapi berbagai situasi praktik kebidanan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-62-6 (PDF)



9

786347

756626

